

TOMAS JARA SCHOCH

Status et examens cliniques

Préparation aux Skills et aux ECOS

Pour la volée de 5ième de 2017-2018

MED II-VI : 2012-2017

CONTENU

Avant-propos	9
Cadre	10
Anamnèse	10
Structure de l'anamnèse	10
Prise de contact	10
Motif de consultation	11
Anamnèse actuelle	11
Antécédents personnels	12
Anamnèse personnelle	12
Aborder les facteurs de risques	13
Aborder la sexualité	13
Antécédents familiaux	13
Anamnèse psychosocial et professionnelle	14
Anamnèse par système	15
anamnèse générale	15
Echelle de dyspnée du MRC	15
Douleur rétrosternale	15
Respiration	16
Anamnèse Générale écrite	17
Anamnèse générale rapide	18
Introduction	19
Plan	19
1. Demander la permission	19
2. Historique	19
Informer et conseiller	19
3. Explorer les avantages et les inconvénients	19
4. Evoquer et renforcer le changement	20
Les outils	21
L'alliance thérapeutique	21
L'écoute réflexive	21
Le discours-changement	22
Les barrières	23
Réflexe correcteur	23
Ambivalence	23
Résistance	23
entretien d'annonce de mauvaises nouvelles	24

Objectifs	24
Ethique	24
Qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle pour un patient?	24
EPICES	24
E comme environnement	24
P comme perception du patient (ou des proches)	25
I comme invitation	25
C comme connaissances	25
E comme empathie	26
S comme stratégies et synthèse	26
Anamnèse sexuelle	27
Investigation psychiatrique	30
Anamnèse psychiatrique	30
La conduite de l'entretien	30
Anamnèse	31
Status psychiatrique	31
Impression générale	31
Psychomotricité	32
Troubles cognitives	32
Langage	33
Pensée	34
Délire, troubles du moi et des perceptions	35
Affects (émotions observées) et troubles affectifs	37
Troubles anxieux (phobies, obsessions, impulsions, compulsions)	39
Troubles somatiques et du dynamisme	40
Idées suicidaires et hétéro-agressivité	40
Examen ORL	41
Anamnèse ORL	41
Status ORL	42
Palpation cervicale	42
Inspection buccale	43
Laryngoscopie indirecte	44
Inspection du nez	45
Inspection de l'oreille	46
Complément : examen oto-neurologique	46
Examen gynécologique	47
Anamnèse	47

Status gynécologique	47
En position assise	47
En position couchée	49
Palpation des ganglions lymphatiques	51
Examen obstétrique	52
Inspection et palpation abdominale	53
Inspection des organes génitaux externes	53
Inspection de la région anale	57
Examen au spéculum	58
Palpation vaginale bimanuelle (permet d'examiner l'utérus)	60
Palpation recto-vaginal	62
Palpation rectale	62
Examen neurologique	63
anamnèse neurologique	63
Préambule	63
anamnèse spécifique	63
Status neurologique	64
Fonction cognitive	65
Examen des nerfs crâniens	65
Système moteur	91
Pratique	92
Réflexes	100
Théorie	100
Pratique	101
Examen vasculaire	111
Palpation des pouls et mesure de la fréquence cardiaque	111
Les pouls	111
Fréquence cardiaque	112
Mesure de la pression artérielle	112
Description des bruits de Korotkoff	113
Pratique	113
Interprétation	114
Affections	114
Examen cardiaque	115
Théorie	115
Bruits cardiaques	115
Dédoublément B2	116

Zones (foyers) d'auscultation	116
Choc de pointe (choc apexien)	117
Utilisation du stéthoscope.....	117
Position.....	117
Pratique	118
Anomalies du choc de pointe	120
Anomalies des bruits	121
Souffles cardiaques	124
Examen pulmonaire	128
Pratique	128
partie antérieure	128
Partie postérieure	132
Bruits pulmonaires	135
Examen de l'abdomen	137
Anamnèse chirurgicale.....	137
Histoire abdominale.....	137
Douleur	137
Médicaments	137
anamnèse générale.....	137
Tabac, OH, Drogues, Toxiques	137
Allergie (type de réaction).....	137
Anamnèse systématique	138
Si opération prévue.....	138
Status de l'abdomen	139
Conditions générales	139
Positionner le patient.....	139
Observer	139
Auscultation.....	140
Percussion	140
Palpation	141
Le foie.....	143
La rate	144
Les reins.....	145
Aorte	147
Orifices herniaires	147
Inspection anale	148
Investigation pédiatrique.....	149

Consultation pédiatrique	149
Status du nouveau-né	150
Objectifs	150
Avant l'examen	150
Evaluation de la croissance intra-utérine	150
Examen Général.....	151
Examen par système	153
Conseils aux parents avant le retour à domicile	157
Alimentation.....	157
Vitamines.....	157
Signes et symptômes d'appel.....	157
Visites chez le pédiatre.....	158
SOINS de base	158
Prévention SIDS.....	158
Prévention accidents.....	158
Prévention de la plagiocéphalie positionnelle.....	159
Développement de l'enfant	159
Moteur	159
Psychosocial	159
Langage.....	159
Intelligence	160
Consultation de l'adolescent	161
Programme de la consultation	161
Cadre	161
Anamnèse psycho-sociale: HEAADSSS	161
Examen physique	164
Conclusion	164
Aborder l'adolescent	164
Examen ophtalmologique	165
Status ophtalmologique.....	165
Inspection œil et annexes.....	165
Eversion de la paupière supérieure	166
Examen du champ visuel.....	166
Etendue du champ visuel	167
Oculomotilité.....	168
Examen des pupilles.....	169
Acuité visuelle	170

Vision des couleurs.....	170
Examen du fond d'œil avec pupille non dilatée	170
Examen et cotation articulaire.....	172
Objectifs	172
Connaître l'utilisation du goniomètre	172
Distinguer la mobilité passive de l'active	172
Utiliser la cotation articulaire internationale et sa notation	172
Théorie	172
Epaule.....	172
Genou	173
Pratique	173
Examens ostéo-articulaires	177
GALS	177
Questions	177
Examen clinique.....	178
Examen clinique de l'épaule	186
Généralité.....	186
Examen physique	186
Examen clinique de la main	193
Fracture du radius	194
Fracture du scaphoïde.....	195
Fracture du doigt	196
Plaies dorsales	196
Plaies palmaires	196
Syndrome du canal carpien	197
Examen clinique du rachis	199
Inspection	199
Mobilité	199
Examen clinique de la hanche et du Genou.....	202
Hanche	202
Genou	207
Examen clinique de la cheville et des pieds	213
Connaissances de base.....	213
Inspection	215
Palpation	217
Mobilisation	218
Introduction	220

1er cours	220
Champs stérile	221
Enlever les points de sutures	223
Prises de sang	226
Injections	231
Introduction	231
Préparation du matériel	231
Sites d'injection	232
Méthode	233
Risques	239
Sonde vésicale	241
Quelles sont les personnes qui nécessitent la pose d'une sonde vésicale?	241
Choisir la sonde	241
Matériel	242
Déroulement	242
Risques	250
Perfusion Intra-veineuse	250
Démarche	250

AVANT-PROPOS

Ce polycopié décrit les différents examens cliniques et status abordés durant la deuxième année et troisième année Bachelor de médecine à l'Université de Lausanne.

La bibliographie utilisée pour la rédaction comprend les divers supports de cours, des annotations personnelles et des éléments du livre « Guide de l'examen clinique » écrit par Barbara Bates et Lynn S. Bickley publié aux éditions « Arnette ». Je vous conseille vivement l'achat de ce livre de référence. D'autres images et informations proviennent de sites Internet. J'ai fait de mon mieux pour indiquer les passages qui se sont inspirés de la bibliographie. Le texte de couleur verte correspond à des passages puisés dans les références.

Ce polycopié a été rédigé par un étudiant dans le but de servir de complément aux cours. Il contient probablement des erreurs et des fautes d'orthographe. Je vous prie, d'avance, de m'en excuser.

Ce polycopié ne constitue, en aucun cas, un support de cours et ne remplace pas les documents fournis dans le cadre de l'enseignement. Je vous conseille d'ailleurs de participer au cours.

Je tiens à remercier Antoine Bruge, Olivia Corda, Léo Fumeau, Raphaël Jenelten et Yoann Aubry pour leur collaboration et pour m'avoir donné la permission d'insérer leurs images dans ce polycopié.

Bonne lecture!

Tomas Jara Schoch

CONSULTATION

CADRE

- Se présenter :
 - Nom
 - Fonction
 - Nom du supérieur et lieu de travail
 - Serrer la main
- Utiliser un désinfectant avant et après le status
- Se placer à droite du patient lors du status
- [...]
- Résumer et énoncer les perspectives
- Serrer la main en prenant congé.

ANAMNÈSE

STRUCTURE DE L'ANAMNÈSE

1. Motif de consultation
2. Anamnèse actuelle
3. Antécédents personnels
4. Anamnèse personnelle
5. Antécédents familiaux
6. Anamnèse psychosocial
7. Anamnèse par système
8. Examen clinique (status) général et par système
9. Résumé : liste des problèmes, diagnostic différentiel, stratégie diagnostique et thérapeutique
10. Traitements

PRISE DE CONTACT

- Se désinfecter les mains
- Saluer : « *Bonjour* »
- Serrer la main
- Se présenter (prénom et nom) : « *Je m'appelle ...* »
- (Demander son nom et son âge)
- Inviter à s'asseoir si besoin
- S'assurer que le patient est disponible :
 - « *Est-ce que vous êtes à l'aise ?* »
 - « *Est-ce que vous m'entendez correctement ?* »
 - « *Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez froid ?* »

MOTIF DE CONSULTATION

- « *Qu'est-ce qui vous amène ?* », « *Qu'est-ce que je peux peut faire pour vous ?* »
(Question la plus ouverte possible)
Le patient n'est pas nécessairement atteint dans sa santé (plainte souffrance), il peut demander une consultation pour faire un bilan de santé (on présume qu'il est en bonne santé).
- Ne pas interrompre le patient ; lui laisser tout le temps nécessaire pour répondre.

ANAMNÈSE ACTUELLE

RLQCCSMA8 : reformulation, localisation, qualité, chronologie, conditions, modifications, associations

- Préciser le motif de consultation :
 - Reformuler : « *Vous me dites que vous avez mal au ventre (?)* » « *[...], c'est-à-dire ?* »
 - ➔ Permet d'ordonner les réponses apportées par le patient.
 - ➔ Assure le patient de l'écoute du médecin.
 - Localiser : demander au patient de signaler le lieu de sa douleur (si nécessaire) :
« *Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous avez mal ?* »
 - Qualité (serrement, colique, spasme, brûlure, décharge électrique, constriction, serrement, pression, sensation de déchirement, d'arrachement, aigue, en coup de poignard, brûlure, piqure d'aiguille, sourde) :
« *Comment se manifeste cette douleur ?* » « *Quel type de douleur ressentez-vous ?* » « *Est-ce une brûlure ? une pression ? un coup de poignard ? une sensation de déchirement ?* »
Utiliser des métaphores, des comparaisons : « *Est-ce que ça vous serre comme un casque ?* »
 - Intensité et irradiation :
« *Est-ce que cette douleur est homogène ?* » « *Est-ce que la couleur est toujours identique ?* »
« *Est-ce que cette douleur est la même partout ?* » « *Est-ce que cette douleur se propage ?* »
 - Définir la chronologie (début, fin, durée, fréquence) :
« *Quand est-ce que vous avez mal ?* » « *Pendant combien de temps avez-vous mal ?* » « *Quand est-ce que la douleur se termine ?* » « *Combien de fois se manifeste cette douleur ?* »
 - Conditions de survenue : aucune, effort, froid, stress, respiration, toux, mouvements du tronc, repas riche, se pencher en avant, au coucher, déglutition d'aliment) :
« *Quand est-ce que cette douleur apparaît ?* »
 - Facteur modifiant le symptôme : repos, soulagée en position assise, aggravée en position couchée, prise de médicaments :
« *Est-ce qu'il y a des facteurs/des circonstances qui modifient cette douleur ?* »
 - Manifestations associées : douleur, dyspnée, nausée, vomissements, toux, sueurs, syncope, paralysie, dysphagie, plaintes diffuses :
« *Est-ce que vous ressentez d'autres manifestations ?* »

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

MATOA6 : Maladies, allergies, traitements, opérations, accidents, hospitalisation

Informez le patient que l'on va aborder ses antécédents : « Je vais vous demander quelques informations sur votre état de santé. »

- Les maladies et leurs traitements
« Est-ce que vous souffrez/avez souffert d'autres maladies ? » « Lesquels ? »
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations
« Est-ce que vous vous êtes déjà rendu chez un autre médecin ? » « Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? » « Est-ce que vous avez subi une opération ? » « Pour quelles raisons ? »
- Chronologie, circonstances, médecins, hôpitaux
- Allergies :
« Est-ce que vous souffrez d'allergies ? » « Avez-vous réalisé des tests ? »
- Médicaments :
« Est-ce que vous suivez un traitement ? » « Quel traitement suivez-vous ? » « Qui est-ce qui vous a prescrit ce traitement ? » (« Pour quelle raison et depuis quand ? »)

ANAMNÈSE PERSONNELLE

GVEEAR6 : général, vaccination, environnement, exercice, alimentation, risque, sexualité

Informez le patient que vous souhaitez aborder ses antécédents : « Je vais vous poser quelques questions sur votre vie personnelle. »

- Etat général ressenti par le patient
- Les vaccinations
« Est-ce que (à votre connaissance), vous vous êtes fait vacciner ? Quels vaccins ? »
« Pour quelle raison vous êtes-vous fait vacciner ? »
- Les risques liés à l'environnement :
 - Habitat : « Où est-ce que vous habitez ? »
 - Zone à risque : « Est-ce que vous êtes proches d'une zone à risque (chimique, sismique, stagnation d'eau, égouts) ? »
 - Exposition : « Est-ce que vous êtes exposés à des produits toxiques ? »
- Exercice, loisirs et voyage
« Que faites-vous de votre temps libre ? »
« Est-ce que vous pratiquez du sport ? Quel type ? Quelle fréquence ? »
- Habitudes alimentaires :
« Est-ce que vous arrivez à vous nourrir correctement ? »
« Quel est votre poids ? » « Comment évolue votre poids ? » (constant ou variable)
« Est-ce que vous avez des problèmes lorsque vous vous rendez aux toilettes ? »
- Facteur de risques : alcool, tabac, substances toxiques
- Sexualité

ABORDER LES FACTEURS DE RISQUES

- Prévenir et rassurer :
« C'est une question de routine : ... »
« Est-ce que vous consommez d'autres substances ? »
- Consommation :
 - Tabac : « Est-ce que vous fumez ? Quel type (cigarette, ...) ? A quelle fréquence ? »
 - Alcool : « Est-ce que vous buvez de l'alcool ? » « Quelle est votre consommation d'alcool ? » (modérée ?) « Quelle est la fréquence ? »
 - Drogues :
« Est-ce que vous avez déjà consommé une drogue (forte) ? »
« Est-ce qu'il vous arrive encore d'en consommer ? Quelle fréquence ? Quel type ? »
- Déterminer l'incidence :
« Est-ce cette consommation a des répercussions sur votre vie (de tous les jours) ? »
- Arrêt : « Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter ? »
- Conseiller et donner des perspectives

ABORDER LA SEXUALITÉ

Cf. anamnèse sexuelle

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

DRHM₄ : décès, risque, héréditaire, maladie

Informez le patient que vous souhaitez parler de sa famille : « Je souhaiterais vous poser quelques questions sur votre famille. ».

- Pathologies retrouvées dans la famille :
 - Pathologies (et causes de décès) des parents (à quel âge?)
 - Pathologies des frères et sœurs (à quel âge?)
 - Pathologies chez les enfants
- Décès :
« Comment se portent vos parents ? »
« Quelle est la cause de décès de vos proches ? »
- Facteurs de risque :
« Est-ce que vos proches fumaient ? »
« Est-ce qu'ils avaient des problèmes d'alcool ou de drogue ? »
- Maladie héréditaire :
« Est-ce que vous ou vos proches êtes porteurs, à votre connaissance, d'une maladie héréditaire ? »
« Est-ce que vous êtes porteur d'une maladie génétique ? »
- Affection actuelle :
« Est-ce que un de vos proches a déjà présenté les symptômes que vous présentez actuellement ? »

ANAMNÈSE PSYCHOSOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Informez le patient que vous souhaitez, à nouveau, de lui de lui et son état d'esprit : « J'aurai encore besoin de quelques informations... ».

- La situation sociale (état civil, vie de famille) :
 - Famille : « *Quel est votre état civil ?* » « *Avez-vous des enfants ?* » « *Est-ce que vous les voyez fréquemment ?* » (permet de déterminer le type de relation et savoir si on peut les contacter en cas d'urgence)
« *Comment se déroule votre vie de couple/famille ? (Est-ce que ça se passe bien dans votre famille ?)* »
- La vie au quotidien (déroulement de la journée) :
« *Comment se déroule votre journée ?* »
- L'activité professionnelle :
« *Est-ce que vous avez une activité professionnelle ?* » « *Laquelle ?* »
- Le parcours de vie
- Les croyances religieuses
- Impact de la douleur :
 - Chercher le degré d'impact :
 - « *Quel est l'impact de cette douleur dans votre vie ?* » (sentimental, travail)
 - « *Est-ce que vous dormez bien ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez affaibli ?* »
 - « *Comment est-ce que vous vous sentez au niveau de l'humeur ?* »
 - « *Quel est l'impact de cette douleur dans votre vie ?* »
 - « **Comment gérez-vous cette situation ?** »
 - « **Est-ce que ça vous inquiète ?** »
 - « **Est-ce que ça vous pèse ?** »
 - Variation de la douleur :
 - « *Quand est-ce que cette douleur augmente/diminue ?* »
 - « *Est-ce que ces conflits génèrent du stress ?* »
 - « *Quand, où, est-ce que cette douleur se soulage ?* »
 - NB : Si la douleur augmente, elle peut aussi diminuer. Insister sur la **variabilité** !
 - Perspectives :
 - « *Qu'est-ce que vous ferez aller mieux ?* »
 - « **Dans quelle situation vécue, vous êtes-vous senti mieux/à l'aise ?** »
 - « *Est-ce que vous avez besoin de soutien ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez dans le besoin de parler à quelqu'un ?* »
 - « *Est-ce que vous en avez parlé avec vos proches ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entourage (dans votre maladie) ?* »
 - « *Est-ce que vous avez déjà essayé de vous faire aider ?* »
 - « *Est-ce que vous avez été suivi par un psychothérapeute ?* »

ANAMNÈSE PAR SYSTÈME

Pour tout symptôme pathologique, se renseigner sur la :

- Localisation
- Qualité
- Intensité
- Situation et survenue
- Facteurs aggravant et soulageant
- Réponse au traitement

ANAMNÈSE GÉNÉRALE

- Paramètres :
 - Etat général
 - Poids (évaluer perte, gain, cinétique) ? Perte d'appétit? Asthénie?
 - Température (mesurée)? Etat fébrile? Frisson? Sudations (nocturnes) ?
 - Adénopathies
 - Allergies

+ demander si bruits respiratoires quand reprise du souffle ; demander si expectorations à l'effort

- Cardiaque :
 - Dyspnée? Quel degré? Orthopnée ? Dyspnée paroxystique nocturne? Quel degré?
« Avez-vous de la peine à respirer? »
 - Douleur rétro-sternale ?
« Ressentez-vous une douleur ou une gêne à la poitrine? »
 - Œdèmes des membres inférieurs ?
« Avez-vous déjà eu un gonflement quelque part? Vos chaussures/vos bagues/votre ceintures sont-elles devenues trop serrées? »
 - Palpitations (perception désagréable des battements cardiaques)?
« Vous arrive-t-il de percevoir les battements/les accélérations de votre cœur? A que cela ressemble-t-il? » -> Demander au patient de battre le rythme avec une main ou un doigt
 - Syncope
« Avez-vous perdu connaissance récemment? »
 - Cyanose
 - Nycturie

Pour syncope : demander combien de temps et dans quelle situation.

Pour nous : 4 stades de dyspnée :

I : ø de limitation

II : Effort important

III : Effort modéré

IV : Au repos

ECHELLE DE DYSPNÉE DU MRC

- Degré 1 : patient avec dyspnée lors d'un exercice intense.
- Degré 2 : dyspnée lors d'une marche rapide sur terrain plat ou en montant une pente légère.
- Degré 3 : marche plus lentement que les personnes de son âge sur terrain plat, ou doit s'arrêter pour respirer lorsqu'il marche à son propre rythme sur terrain plat.
- Degré 4 : doit s'arrêter pour respirer après une marche d'environ 90 mètres.
- Degré 5 : trop essoufflé(e) pour quitter la maison, ou dyspnée lors de l'habillement.

DOULEUR RÉTROSTERMALE

- Respiro-dépendante : pneumothorax, péricardite, embolie pulmonaire
- Au toucher: atteinte musculo-squelettique
- Permanente : infarctus

- Pulmonaire :
 - Dyspnée ?
 - Douleur thoracique ?
 - Toux ? Depuis combien de temps?
 - Ronflements
 - Expectorations :
 - Quantité : petite quantité ? abondamment?
 - Couleur : rouge (**hémoptysie**) ? verdâtre? transparente (glaires)?
- Abdominale :
 - Dysphagie (liquides, solides) ?
 - Nausées, vomissements ?
 - Douleurs abdominales? Pyrosis?
 - Réplétion gastrique?
 - Selles : fréquence? Qualité? **Sang**? Couleur? Odeur ? Incontinence ? Gaz?
 - Ictère

RESPIRATION

- Effort (respiration difficile non angoissante) <- effort musculaire
- Suffocante, angoissante <- BPCO, insuffisance cardiaque
- Serremment, poitrine serrée <- asthme et fibres vagues

	Douleur viscérale	Douleur somatique
Neurologie	sympathique + parasymphatique	nerfs spinaux
Origine	infiltration, étirement spasme, ischémie	paroi abdominale (péritoine pariétal incl.)
Caractère	mate, profonde, térébrante, colique	aigue, brûlante
Localisation	difficile	précise
Symptômes végétatifs associés	fréquent	rare

Schmerztyp	Diagnose			
 Perforation	 Ulcerperforation	 Mesenterialinfarkt	 Gallenblasenperforation	
 Kolik	 Gallenkolik	 Uretersteinkolik	 Ileus	
 Entzündung	 Appendizitis	 Pankreatitis	 Cholezystitis	

Bristol Stool Chart		
Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on the surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid

- Urinaire :
 - Dysurie (difficulté à l'évacuation de l'urine)?
 - Diminution de la force du jet?
 - Pollakiurie (fréquence excessive des mictions) ?
 - Incontinence
 - Algurie (douleurs et brûlures à la miction)?
 - Douleurs et crampes dans le bas ventre? dans le dos?
 - Couleur de l'urine ? Jaune? Brune ? Rouge?

- Neurologique :
 - Vertiges ?
 - Céphalée ? Raideur de nuque ?
 - Troubles visuels? Diplopie ? Photophobie ?
 - Trouble de l'audition ? Hypoacousie?
 - Troubles moteurs ? Diminution de la force ?
 - Troubles de la sensibilité ? Diminution de la sensibilité? Paresthésies?
 - Troubles de l'équilibre? Trouble de la marche?
 - Douleurs (décharge électrique, brûlure) ?
 - Troubles cognitifs (Mini Mental State)

ANAMNÈSE GÉNÉRALE ÉCRITE

[...] : à compléter

.../... : choisir selon l'individu

En gris : selon le status, ne doit pas figurer obligatoirement sur le rendu écrit.

Anamnèse

Il s'agit d'un/une patient/patient de [âge] ans, connu/connue pour une/des [antécédents pertinents pour la prise en charge] qui [consulte aux urgences/qui est adressé par son médecin généraliste] pour une [signe/symptôme principal] apparue il y a [description temporelle]. Monsieur/Madame se plaint [description détaillée de la plainte : anamnèse actuelle].

[...]

Les reste de l'anamnèse n'est pas contributive.

Status écrit

Paramètres : [TA] mmHg, [FC] bat/min, [Température] °C, [Sat] %, orienté/orientée aux 3 modes, [glycémie]

CV : rythme normo/brady/tachy-carde irrégulier/régulier avec B1-B2 bien frappés/lointains, souffle [description]/sans bruits surajoutés, bonne perfusion périphérique avec tous les pouls distaux palpables/malgré des pouls distaux non palpés, turgescence/oedème/reflus hépato-jugulaire présent

Pulm : murmure respiratoire présent et symétrique /râles crépitants aux deux bases.

Abdo : abdomen souple et indolore/défense et détente abdominales, bruits normaux en tonalité et en fréquence, loges rénales souples et indolores/sensibles et douloureuses, percussion douloureuse, toucher rectal

Neuro : GCS de [...]/orienté/e aux 3 modes/bien éveillé/collaborant, pupilles isocores et isoréactives, NC (III - XII) sans particularités, sensibilité présente/préservée/diminuée/absente et symétrique/conservée aux 4 membres, M[échelle de force] aux 4 membres, ROT et cutané-plantaire normo/hypo-vif et symétrique, marche non testée, diadococinésie et dysmétrie sans particularités, rigidité/spasticité, signes méningés, bras-tendu/Romberg/talon-genou/rebond sans particularités

ANAMNÈSE GÉNÉRALE RAPIDE

Par système :

- Cardio-pulmonaire :
 - Dyspnée ? (*mal à respirer*) -> Si oui : orthopnée ?
 - Toux ?
 - Crachats ? -> Si oui : aspect ? + syncope
 - Douleurs thoraciques ?
 - Palpitations ? (*cœur bat plus vite*)
 - Œdèmes ? (*jambes gonflées*)
- Digestif :
 - Diarrhée ? (*fréquence des selles*)
 - Date des dernières selles ?
 - Sang ou selles noires ?
 - Nausées ? Vomissements ?
 - Mal au ventre ?
- Urologique :
 - Urine plus fréquemment ?
 - Douleurs lorsqu'il urine ?
 - Sang dans les urines ?
- Neurologique :
 - Céphalée
 - Pertes de force, de sensibilité, de la coordination, de la marche ?
 - Vertiges (*tête qui tourne*)

Etat général :

- Fièvre
- Poids
- Transpiration

Pathologie thoracique urgente : dissection aortique ; infarctus du myocarde ; oedème pulmonaire ; tamponnade ; embolie pulmonaire ; pneumothorax.

Douleurs thoraciques non cardio-pulm : Les douleurs oesophagiennes : Reflux gastro-oesophagien, spasme de l'oesophage, rupture de l'oesophage (rare)

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

INTRODUCTION

La façon dont nous nous adressons à un patient par rapport à sa santé peut influencer sa motivation à changer son comportement.

L'entretien motivationnel est une technique qui vise à aider le patient à changer son comportement. Il se fonde sur l'idée qu'une personne n'arrivera à des changements que si la motivation vient de la personne elle-même. Son but est donc de susciter et renforcer cette motivation.

PLAN

1. DEMANDER LA PERMISSION

- « *Seriez-vous d'accord que l'on discute un moment de... ?* »
- « *Est-ce que vous seriez d'accord que l'on discute (un petit moment) des facteurs de risque – ces choses qui ne sont pas bonnes pour la santé – pour ... ?* »

2. HISTORIQUE

- Inviter le patient à élaborer, à participer en lui demandant de raconter son histoire.
« *Parlez-moi un peu de votre consommation de ...* »
« *Racontez-moi un peu comment vous avez commencé à ... / comment est apparu votre... ?* »
- Développer à partir des connaissances du patient

INFORMER ET CONSEILLER

(Pas toujours nécessaire)

- Identifier les connaissances du patient : « *Que savez-vous déjà de ... ?* »
- Identifier les besoins du patient : « *Que souhaitez-vous savoir à propos de ... ?* »
- Informer : compléter, ajuster, fournir l'information/les conseils de façon neutre
TOUJOURS DEMANDER : « *Vous avez raison et je me rends compte que vous savez beaucoup de choses. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne davantage d'informations ?* »
- Explorer ce que le patient a compris et les implications : « *Qu'est-ce que vous en pensez ?* » « *Que faites-vous de cela ?* » « *Qu'est-ce qui a été utile ?* » -> Le patient doit s'approprier cette information

3. EXPLORER LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS

Questions types :

- « *Qu'est-ce qui vous semble difficile/pénible avec ... ?* »
- « *Qu'est-ce qui vous dérange avec ... ?* »
- « *Parlez-moi de vos craintes par rapport à ... ?* »

- « *Qu'est-ce qui est (malgré tous les problèmes que vous avez aujourd'hui) ok/bien avec ... ?* »
- « *Quelles sont les bonnes choses/les avantages de la situation actuelle ?* »
- « *Qu'est-ce que ça vous apporte/vous amène ?* »
- « *Que voyez-vous encore ?* »

Style de communication : **Suivre**

- But :
 - Laisser le patient exprimer vécu émotionnel afin de mieux comprendre le patient -> bien comprendre permet de mieux aider.
- Comment ? Ecoute centrée sur le patient :
 - (Demander la permission)
 - Laisser exprimer
 - Ecouter
 - Répéter, paraphraser et refléter -> approfondissement des émotions du patient

4. EVOQUER ET RENFORCER LE CHANGEMENT

Questions types :

- « *Je vous propose d'imaginer/ imaginez que vous déjà pris la décision de faire quelque chose par rapport à Quels seraient les gains potentiels, les bénéfices, les aspects positifs ?* »
- « *Qu'est-ce qui serait différent par la suite si vous arriviez à changer ces comportements/ si les choses changeaient ?* »
- « *Si vous deviez atteindre cet idéal, qu'est-ce qui se modifierait par la suite ?* »

Style de communication : **Guider**

- But :
 - Evoquer et renforcer une motivation à changer de comportement. Pourquoi évoquer le changement ?
 - L'évocation du changement permet au patient de verbaliser les avantages d'un changement et de lui donner envie de l'atteindre. Le but est d'augmenter la motivation du patient en lui faisant explorer ce qui pourrait être mieux dans sa vie.
 - Attention, il est important ça soit le patient qui évoque le changement et élabore les pistes pour l'atteindre.
- Comment ?
 - Écoute empathique ciblée
 - Favoriser l'exploration de la situation
 - Evocation du changement -> utiliser le conditionnel : le conditionnel permet d'explorer le changement sans se sentir contraint de s'y engager et sans que son exploration ne soit limitée par des blocages éventuels (craintes, difficultés).
 - Reflets sélectifs (pour que la réflexion suive une direction particulière) -> Quelle direction ? : **renforcer les aspects du changement**
 - Augmenter l'importance que le patient accorde au changement individuel.

« Permettez-moi de chiffrer des choses qui ne sont pas chiffrables comme si on utilisait un thermomètre. Quelle serait l'importance pour vous d'effectuer ce changement/ de changer sur une échelle de 0 à 10 (= étant pas du tout important et 10 très important) ? Comment vous situez-vous ? »

« Qu'est-ce qui vous fait dire 7 plutôt que 4 ? »

« Pourquoi le changement est si important ? »

- Augmenter la confiance du patient dans sa capacité à atteindre le changement.

« Si vous décidiez d'effectuer ce changement, quelle serait la confiance que vous auriez en votre capacité de réussir sur une échelle de 0 à 10 ? »

« Qu'est-ce qui vous fait dire 4 plutôt que 1, par exemple ? Comment cette confiance pourrait passer de 4 à 7 ? »

« Comment votre confiance pourrait se renforcer ? »

- Utiliser le discours-changement.

LES OUTILS

L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE

- Comment créer l'alliance thérapeutique ?
 - Méthode : utiliser l'empathie pour créer un climat de confiance et éviter toute confrontation.
 - Attitude : bien connaître les produits d'addiction tout en adoptant une position d'écoute.
 - But : pointer les contradictions entre les bénéfices ressentis sous produits et les conséquences inéluctables sur la vie personnelle sans confrontation. L'objectif n'est pas de convaincre mais de restituer un bilan le plus fidèle possible de la situation afin de provoquer une prise de conscience.

L'ÉCOUTE RÉFLECTIVE

- Définition : l'écoute réflexive permet de vérifier la communication soignant – patient (de vérifier si ce que le soignant pense que le patient a dit est bien ce que le patient a voulu dire) et de tester des hypothèses (formulée sous forme d'affirmation). Le but est de compléter les informations en reformulant ou en confrontant et d'explorer l'envie et les obstacles au changement.
- Méthodes :
 - Reflet simple (RS) :
 - Affirmation neutre qui est une reformulation d'une phrase verbalisée par le patient.
 - Reflet complexe (RC) :
 - Affirmation qui interprète et verbalise l'émotion sous-jacente du discours de patient et qui confronte le patient à une contradiction ou à une vérité (une émotion qu'il ignore).
 - Reflet de sentiment (RdS) :
 - Affirmation empathique qui interprète et verbalise un sentiment (sous-jacent du discours de patient) afin de susciter une réflexion chez le patient (voire une confrontation) et créer un rapprochement soignant – patient.
- Exemples :
 - 1^{er} exemple : « Ca me dérange terriblement d'avoir ces coups de pompes car ça me fait dormir. Ca m'ennuie car lorsque je rentre à la maison, j'ai beaucoup de chose à faire. Parfois, en fin de journée, j'ai envie de boire un petit apéritif. J'ai l'impression que ça va me donner du courage pour continuer à fonctionner. »
 - RS : « L'alcool vous donne du courage. »

- RC : « L'alcool vous donne du courage mais en même temps il est à l'origine de votre fatigue et de vos coups de pompes »
- RdS : « J'ai le sentiment/l'impression que vous vous sentez tiraillé entre les différents effets de la consommation d'alcool. D'un côté l'alcool vous donne du courage et de l'autre côté il vous fatigue. Vous devez vous sentir un peu perdu. »
- 2^{ème} exemple : « Ce qui me paraît pénible avec mon poids ?! Il y a l'aspect social : la manière de se présenter aux autres, le jugement que certains semblent exprimer par leur attitude. Il y a une forte pression sur le paraître... Mais aussi des choses plus personnelles : le fait de se déplacer avec plus de difficulté, d'être essoufflé. Ce genre de chose... »
 - RS : « J'entends bien/ je comprends bien que votre poids actuel vous gêne à cause du regard des autres, qui peut parfois être jugeant, et aussi parce que vous vous déplacez plus difficilement et que vous êtes essoufflé. »
 - RC : « Le regard des autres, leurs jugements, votre peine à vous déplacer, votre inconfort vous indiquent, voire vous incitent peut-être, à vouloir modifier quelque chose dans votre situation actuelle. »
 - RdS : « J'ai l'impression que vous subissez/souffrez du regard des autres et des répercussions plus personnelles de votre poids. »
- Modèle d'échange d'informations :
 - Faire évoquer :
 - « Que savez-vous au sujet de... ? »
 - « Que voulez-vous savoir à propos de... ? »
 - « Seriez-vous d'accord que je vous explique... ? »
 - Informer :
 - Donner l'information en s'assurant d'en avoir la permission.
 - Parler de ce qui marche pour d'autres.
 - Donner des choix.
- Faire évoquer :
 - « Que faites-vous de cela ? »
 - « Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous ? »

LE DISCOURS-CHANGEMENT

- Définition : tous les propos du patient qui expriment sa motivation à changer/ tout ce qui est dit par le patient en faveur du changement.
Il dépend de l'importance que revêt le changement aux yeux du patient ou de la confiance qu'il a en sa capacité à le réaliser.
 - Discours-maintient : tous les propos du patient qui expriment sa motivation à ne pas changer. <- à éviter !
- Méthode :
 - Reconnaître le discours-changement :
 - Désir : « J'aimerais bien arrêter de fumer. »
 - Besoin : « Je dois absolument perdre du poids. »
 - Raison : « Je dois changer, car ma femme ne me supporte plus comme ça. »
 - Capacité : « Je sais que si je le veux vraiment, je suis capable de tenir bon. »
 - Renforcer le discours-changement :
 - Elaboration : « Comment pourriez-vous vous y prendre ? »
 - Reflet
 - Valorisation : « Vous vous sentez assez fort pour réussir à tenir bon. »
 - Résumé

- Attention, il ne s'agit pas de nier le discours-maintien, de nier le plaisir que peut apporter l'addiction. Au contraire, il est important de légitimer ce plaisir. L'astuce réside de commencer en légitimant le discours-maintien puis d'insister davantage sur le discours-changement.

LES BARRIÈRES

RÉFLEXE CORRECTEUR

- Définition : tendance des professionnels de la santé à vouloir réparer les problèmes de leurs patients.
- Mécanismes :
 - Convaincre le patient qu'il a un problème : « *Vous avez un problème avec l'alcool ; vous buvez trop.* »
 - Argumenter en faveur des avantages du changement : « *Si vous arrêtez de boire, vous serez plus disponible pour votre famille.* »
 - Mettre en garde contre les risques de ne pas changer : « *Si vous continuez à boire, vous allez perdre votre travail.* »
- L'être humain a tendance à résister à la persuasion. Le patient exprime de la résistance face au réflexe correcteur. Il est important d'en être conscient et d'éviter tout réflexe correcteur.

AMBIVALENCE

- Définition : attitude normale qui accompagne le changement de comportement caractérisée par une volonté simultanée de vouloir changer et de ne pas changer.
- Mécanisme : la plupart des gens veulent être en bonne santé et veulent agir dans ce sens, mais en même temps, ils se sentent bien avec leurs habitudes et voient des inconvénients à les changer.
- Le soignant ne doit pas contrer l'ambivalence du patient. Au contraire, il doit accepter l'ambivalence sans jugement et ne pas essayer de le pousser à aller dans un sens ou un autre.

RÉSISTANCE

- Définition : opposition naturelle du patient à l'argumentation du soignant en faveur du côté « santé » de l'ambivalence, qui s'exprime par une argumentation en faveur de l'autre côté, une tendance à relativiser et un entêtement.
- La résistance étant fortement influencée par l'attitude du soignant, son apparition, indique au soignant qu'il doit la changer ; le rôle du soignant est de diminuer la résistance du patient.

ANNONCE DE MAUVAISES NOUVELLES

ENTRETIEN D'ANNONCE DE MAUVAISES NOUVELLES

OBJECTIFS

- Evaluation du niveau de connaissance et des attentes du patient;
- Soutien au patient à l'aide des compétences relationnelles et de l'empathie;
- Permettre l'expression des émotions;
- Elaboration des stratégies de traitement et/ou d'accompagnement possible.

ETHIQUE

Le respect du principe d'autonomie du patient implique :

- De tenir compte du contexte biographique de la personne malade;
- D'intégrer dynamique familiale;
- D'informer le patient et ses proches d'une façon aussi claire et aussi franche que possible;
- De s'assurer que les informations aient été bien comprises;
- De veiller à ce que la volonté de la personne malade soit bien comprise et dans la mesure du possible prise en compte;
- D'orienter les décisions selon les valeurs et les volontés exprimées au préalable, oralement ou par écrit, par le patient incapable de discernement (p.ex. directives anticipées).

QU'EST-CE QU'UNE MAUVAISE NOUVELLE POUR UN PATIENT?

Une information qui affecte inéluctablement et sérieusement la vision du futur d'une personne.¹

EPICES

E COMME ENVIRONNEMENT

Objectifs : préparation de l'environnement extérieur et des dispositions intérieurs des soignants.

1. Préparation de l'entretien :
 - Relire le dossier;
 - Répartir le temps de parole et les objectifs à réaliser entre les différents intervenants;
 - Anticiper les réactions émotionnelles possibles;
 - Prévoir un endroit intime.
2. Saluer et se présenter : « *Bonjour, je suis [prénom et nom], [fonction].* »
3. Créer le cadre de l'entretien : « *Voilà, nous avons 45 min pour faire le point au sujet de...* »

¹ Buckman, R. (1994). *S'asseoir pour en parler*. Paris. InterEditions

P COMME PERCEPTION DU PATIENT (OU DES PROCHES)

Objectif : explorer ce que le patient a intégré de sa situation de manière à pouvoir ajuster l'information que l'on souhaite donner.

4. Explorer les connaissances du patient :

L'information qu'il a déjà reçue et qu'il a comprise : *« Pouvez-vous me dire, en quelques mots, ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre situation ? » « Quelles informations avez-vous déjà reçues ? » « Savez-vous pour quelle raison cet examen a été réalisé ? » « Est-ce que vous me suivez jusque-là ? »*

- Les personnes rencontrées : *« Quels sont les médecins qui vous ont suivi ? »*
- Les représentations qu'il a de cette maladie et de ses conséquences : *« Pour vous, c'est quoi un cancer ? »*
- Les expériences personnelles (famille, proches) qu'il a de cette maladie et de ses conséquences : *« Vos proches ont également souffert de cette maladie ? »*
- Ce qu'il souhaite savoir, aujourd'hui : *« Qu'est-ce que vous attendez de la consultation d'aujourd'hui ? »*

5. Identifier et tenir compte des craintes, des attentes et des mécanismes de défense du patient.

I COMME INVITATION

Objectifs : vérifier si le patient souhaite être informé de « la mauvaise nouvelle » et ainsi pouvoir évaluer les capacités du patient à entendre ce qui doit lui être dit et de respecter son rythme.

Concéder au patient la possibilité de nommer et de mettre des limites permet de renforcer la mise en place de stratégie de coping.

6. Identifier les connaissances que le patient souhaite recevoir : *« Qu'aimeriez-vous savoir à propos de ce qui vous arrive ? » « Quel niveau d'information souhaitez-vous ? » « Avez-vous plutôt besoin de beaucoup de détails sur votre situation, ou alors une image plutôt globale ? »*
7. En cas de refus (d'informations), explorer les raisons afin d'assurer un accompagnement adapté lors des prochaines rencontres : *« Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas savoir davantage ; la plupart des patients veulent savoir plus ? »*

C COMME CONNAISSANCES

Objectifs : annoncer la mauvaise nouvelle

8. Prévenir le patient : *« Nous aurions voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais malheureusement la situation est plus compliquée. »*
9. Donner l'information graduellement: *« Je vais vous annoncer quelque chose difficile. »*
10. Annoncer la mauvaise nouvelle: *« Les résultats des examens nous indique que vous souffrez... »*
11. Laisser ensuite un temps de silence pour évaluer sa réaction.

Techniques :

- Laisser constamment un temps de silence pour évaluer les réactions du patient et de son entourage en s'ajustant à leur niveau de compréhension.
- S'assurer de la compréhension : *« Est-ce que vous me suivez ? »*

- Utiliser un langage accessible et éviter tout jargon médical (mais nommer la maladie par son nom : cancer et non pas grosseur).
- Faire preuve d'honnêteté même si le diagnostic est sombre, et d'éviter les formulations de type « *il n'y a plus rien à faire* ».
- Une mauvaise nouvelle crée un état de choc diminuant ainsi sa capacité à mémoriser et à saisir l'information. Pour y remédier, il faut:
 - Répéter et revenir sur certains éléments.
 - Laisser place aux questions potentielles.
 - Générer des silences «invitants» ou «compassionnels» qui permettent au patient d'exprimer ses émotions et l'aide ainsi à mieux intégrer l'information.

E COMME EMPATHIE

Objectifs: accueillir les réactions émotionnelles

12. L'empathie est attitude relationnelle qui permet de l'autre dans sa souffrance en identifiant son émotion, la cause de celle-ci, et de lui offrir une validation sociale de son vécu. Faire preuve d'empathie permet d'accueillir les réactions émotionnelles.
« *Vous semblez totalement abattu par cette nouvelle!* » (identification) « *Et c'est tout à fait compréhensible...* » (validation) « *Je comprend votre peine et votre souffrance* ». Il faut assurer au patient sa que l'on est là pour lui : « *Je suis là* ». « *Je vais (essayer de) vous aider* ».
13. **Eviter la fausse réassurance** (Vous avez de multiples métastases cérébrales, mais rassurez-vous, on peut irradier et tout ira bien) doit absolument être évitée. C'est un moment d'émotions souvent intenses à partager sans autre intention que celle d'être là pour l'autre.

S COMME STRATÉGIES ET SYNTHÈSE

Objectifs: explorer les perspectives

14. Evaluer avec le patient s'il est prêt à poursuivre l'entretien ou s'il préfère le différer (élaborer un permet de diminuer l'anxiété): « *Je vous propose d'explorer un peu ce qui va se passer ces prochains jours, est-ce que vous en avez envie ? Je comprends bien que c'est un moment difficile pour vous mais parler des prochaines étapes peut peut-être vous soulager ?* »
15. Identifier les ressources du patients et les soutenir: « *J'ai bien conscience que la situation actuelle est difficile. Je voudrais savoir comment vous avez fait par le passé pour affronter les problèmes?* »
 - Stratégies de *coping* (-> recentrer sur le présent et faire surgir une attitude pro-active) : « *Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant ?* » « *Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant ?* »
 - Soutien extérieur: « *Qu'est-ce qui vous soutient aujourd'hui ?* » « *Quels sont les proches sur qui vous pouvez compter ?* » « *Vous voulez que j'appelle quelqu'un?* »
16. Présenter le plan de soins, traitements. Aborder les prochaines étapes médicales permet que le patient ne se sente pas abandonner.
17. Synthèse du contenu, reprise des éléments et réponses aux questions émergentes ou aux propositions concrètes.
18. Donner des délais, des étapes et fixer un prochain RDV pouvoir reprendre les éléments incompris et répondre aux questions qui émergent fréquemment à distance de l'annonce.

EXAMENS

ANAMNÈSE SEXUELLE

- Entretien exploratoire: L'anamnèse sexuelle est difficile pour le patient et le médecin car elle aborde l'intimité du patient, les représentations et les émotions du patient et du médecin
 - Justifier le nécessité de l'anamnèse et prévenir le patient:
 - « Pour compléter/terminer, il faut que je vous pose des questions plus intimes... »
 - « On sait que plusieurs facteurs peuvent affecter la sexualité, c'est pour cela que je me permet de vous poser quelques questions sur votre vie intime »
 - « Ce sont des questions délicates qui peuvent engendrer une certaine gêne, est-ce que ça vous pose problème ? »
 - Rassurer et mettre en confiance le patient:
 - « Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me faire confiance ; je suis soumis au secret médical. »
 - « Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider. »
 - « Est-ce que ça vous fait du bien d'en parler ? »
 - « Si vous sentez mal-à-l'aise, dites-le-moi et, on passe à autre chose. »
 - Ouverture et autorisation :
 - « Est-ce que vous êtes d'accord que je vous pose des questions sur votre sexualité ? »
 - Nommer le climat émotionnel :
 - « Je vois bien que ça vous touche/gêne »
 - « Si les questions vous gênent, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais ça peut m'aider à comprendre où vous en êtes dans votre santé ».
 - Utiliser un langage adapté: signification des mots
 - Investigation ≠ inquisition

Symptômes -> caractéristiques -> contexte -> biographie

- Motif de consultation:
 - Question ouverte :
 - « Etes-vous satisfait de votre sexualité ? »
 - « Comment est-ce que vous vivez votre sexualité ? »
 - « Comment se déroule votre vie sexuelle ? »
 - Si la personne est gênée, énoncer des questions fermées : nombre de partenaire, fréquence des rapports, comportements à risque :
 - « A quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels ? »
 - « Est-ce que vous avez eu ces rapports avec la même personne ? »
 - « Y a-t-il une difficulté dont vous souffrez ? »
- Si motif de consultation :
 - Reformuler
 - (Localiser)
 - Qualité
 - Définir la chronologie: date d'apparition, constance
 - Conditions de survenue: « Comment le problème se manifeste-t-il ? »
 - Facteurs modifiant le symptôme: facteurs aggravants ou améliorants
 - Manifestations associées
- Aspects psychosociaux :
 - Perception: aborder le ressenti et déterminer la représentation individuelle

- « Que pensez-vous de ce problème ? »
- « Quels sont les sentiments que vous éprouvez, lorsque qu'on parle de sujet ? »
- Répercussions:
 - « Qu'en pense votre/vos partenaire/s ? »
 - « Quel est l'impact sur la vie quotidienne ? »
- Ressources et motivations
 - « Avez déjà été confronté à ce genre de problèmes ? »
 - « Avez-vous déjà cherché de l'aide ? »
 - « Avez-vous pris des médicaments ? »
 - « Pourquoi consultez-vous maintenant ? Quelles sont vos attentes ? »
- Troubles:
 - Désir :
 - Trouble sexuel le plus fréquent
 - Chez la femme: après la naissance; chez l'homme: dans le contexte d'un burnout
 - « Comment se porte votre libido ? »
 - « Est-ce que vous avez (toujours) envie/désirez avoir des rapports sexuels ? »
 - Excitation :
 - Chez la femme: manque de lubrification (12-30%), incidence augmente avec l'âge, lors de la ménopause, douleurs (dyspareunie)
 - Chez l'homme: difficultés d'érection, 40-50 ans: 10%, 50-60 ans: 15%, 60-70: 35%, 70-80 ans: 50%, maladies somatiques sous-jacentes, troubles psychiatriques, effets médicamenteux
 - « Est-ce que vous êtes (toujours) excité à l'idée d'avoir des rapports sexuels ? »
 - Plaisir :
 - Dyspareunie, vaginisme (contraction musculaire prolongée)
 - « Est-ce que vous êtes satisfaite de vos relations sexuel/sexualité ? »
 - « Est-ce que vous prenez du plaisir lors des rapports sexuels ? »
 - « Est-ce que vous ressentez une douleur/ une souffrance / une gêne lors de vos rapport ? »
- Questionnement sur orientation sexuelle :
 - « Comment ça se passe avec votre/vos partenaire/s ? »
 - Si le patient n'est pas exhaustif, il ne faut pas laisser qu'un climat d'incertitude s'installe. Il faut poser la question directement: « Quelle est votre orientation sexuelle ? »
- Maladies, traitement, dépendances :
 - « Est-ce que vous souffrez de maladies ayant une influence sur votre sexualité ? »
 - « Est-ce que vous avez été traités pour des MST ? »
 - « Est-ce que vous utilisez des moyens de contraception ? »
 - Responsabiliser la personne sur les moyens de contraception : « N'oubliez-pas d'utiliser un préservatif ! »
 - Si la personne éprouve une honte ou une gêne, se focaliser sur ce sentiment et non pas sur les détails (du rapport sexuel). Montrer son soutien et rediriger vers un spécialiste tout en précisant sa disponibilité : « C'est difficile, je comprends. »
 - « Personne n'est parfait. »
- Vécus traumatiques de la sexualité :
 - « Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience avec la sexualité ? »
 - « Est-ce que vous avez pratiqué des comportements à risque ? »
 - « Est-ce que vous avez subis des rapports sans votre consentement ? »
- Difficulté dans les relations sentimentales et violence conjugale :
 - « Est-ce que vous avez été/êtes violenté/abusé par votre partenaire ? »

- Conclusion :
 - « Je peux, si vous le souhaitez, vous rediriger vers un de mes collègues qui pourra vous apporter un soutien psychologique. Mais, dans tous les cas, je reste une personne de référence et je serai toujours à votre disposition ».

CONSEILLÉ	PAS CONSEILLÉ
Créer un climat accueillant pour inviter le patient à se confier	Supposer que tous les patients gays en font part à leur médecin
Le comportement sexuel n'est pas indicatif nécessairement de l'identité sexuelle	Présumer qu'un comportement sexuel définit l'identité de la personne
Utiliser le langage et la terminologie des patients. Certaines personnes ne se définissent pas comme "gay" même en ayant des rapports sexuels avec des partenaires du même sexe	Utiliser le terme "gay" pour décrire un patient qui dit avoir des partenaires du même sexe
Ne pas faire de généralisations trop simplistes sur les besoins de chacun. La population gay n'est pas homogène, même si elle constitue une même communauté	Prétendre que son patient gay a les mêmes besoins que les autres gays
Trouver une occasion favorable pour parler avec le patient de son état sérologique (VIH et IST) et ainsi aborder avec lui les différentes stratégies de prévention et de réduction des risques	Présumer de l'état sérologique du patient ainsi que de la connaissance qu'il a des IST Oublier de réactualiser les connaissances de la personne
Impliquer le patient dans le processus décisionnel et voir avec lui la démarche d'accès aux différents tests	Prescrire systématiquement le test VIH et d'autres tests à un patient sous prétexte qu'il est gay
Etre attentif au langage qu'on utilise pour qu'il soit le plus approprié possible	Présumer que son patient se sent à l'aise avec des termes comme "partenaire actif" et "partenaire passif"
S'assurer que le patient a ou non des enfants	Présumer que le patient n'a pas d'enfants

Guide pratique santé gay par l'association des médecins gays:

<http://www.medecins-gays.com/nos-actions/actions/guide-pratique-sant%C3%A9-gay/>

INVESTIGATION PSYCHIATRIQUE

ANAMNÈSE PSYCHIATRIQUE

LA CONDUITE DE L'ENTRETIEN

DÉBUT D'ENTRETIEN

- Se présenter, préciser le cadre temporel et les objectifs :
 - « On va commencer par la présentation...
 - ... Je m'appelle [...] et je suis [...] dans le service de [...]
 - ... L'idée est que l'on fasse un peu connaissance durant 1h et que l'on discute librement de ce qui vous amène/ L'idée est de voir où vous en êtes aujourd'hui / L'idée est de comprendre un peu ce qui se passe/ J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce qui vous amène et votre état actuel. Nous avons le temps d'en parler librement.....
 - ... Je vous écoute! »
- Question ouverte:
 - « En quoi puis-je vous aider ? »
 - « Qu'est-ce qui vous amène? »
 - « Qu'est-ce qui vous amène à consulter un psychiatre? »
 - « Pour commencer, je voudrais avoir une idée des problèmes qui vous ont préoccupé au cours du mois qui vient de s'écouler. Quelles ont été vos principales difficultés ? »

EN COURS D'ENTRETIEN

- Le but est de clarifier les éléments apporté par le patient, pour cela il faut :
 1. Reformuler les difficultés décrites et chercher une situation concrète pour analyser les interactions :
 - Donner des détails : « vous voulez m'expliquer en détail ? quand vous dites que vous étiez trop [...], vous pensiez à quoi ? »
 - Donner un exemple : « pouvez-vous me raconter/me faire un exemple ? Pouvez-vous être plus précis ? Dans quelle situation? »
 - Evaluer la réaction : « comment avez-vous réagi à ces propos/cette situation? Vous êtes-vous senti en colère ? Ca vous inquiète ? Si vous êtes en colère qu'est-ce que vous faites ? »
 - Evaluer les capacités/vécus/insight, confrontation: « qu'est-ce qui se passe si vous ne ...? pourquoi cette réaction ? Qu'est-ce que vous avez compris de cette nouvelle? Vous avez une idée sur la cause ? Aujourd'hui vous en êtes là, qu'est-ce que l'on peut faire ? »
 2. Préciser les attentes du patient et les enjeux:
 - « Qu'est-ce qui reste comme difficulté ? »
 - « Pourquoi êtes-vous là? Quels sont les enjeux ? »
 - « Pourquoi consultez-vous maintenant? qu'est-ce qui a changé ? »
 3. Faires des synthèses partielles : « si je vous comprends bien, vous dites que ... »
 4. Interrompre courtoisement : « excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas bien compris... »
- Lorsque le sujet donne une information inadéquate:
 - Propos trop brefs : « pouvez-vous me dire davantage de choses à ce propos ? »
 - Le patient n'a rien à ajouter : « y a-t-il d'autres choses qui vous ont troublé ? »

- Propos incompréhensibles : « *pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par...?* »
- Propos trop vagues : « *pourriez-vous me donner un exemple de...?* »
- Absence de réponse : « *pourquoi êtes-vous venu à l'hôpital/consultation?* »
- Attitude de l'examineur : NEUTRE ET BIENVEILLANTE
C'est-à-dire éviter de prendre position et montrer de l'intérêt pour le récit du patient. Pour cela
 - Éviter les jugements de valeur, même positifs et à but de soutien
 - Montrer son intérêt par des interventions neutres : « *mhhhm* », « *je comprends* », « *c'est possible* », « *en effet* », « *peut-être* ».

EN FIN D'ENTRETIEN

- Faire une synthèse en résumant
- Prendre position sur le plan diagnostique et thérapeutique si la situation est claire et le permet
- Demander au patient si tous les sujets importants ont été abordés et s'il veut ajouter quelque chose.

ANAMNÈSE

- **Motif de consultation**
- **Anamnèse actuelle**
- **Antécédents psychiatriques**
- **Antécédents psychiatrique personnels :**
 - Antécédents d'hospitalisation
 - Suivi psychiatrique ambulatoire
 - Historique de traitements psychotropes
- **Antécédents psychiatriques familiaux :**
 - Présence de pathologies psychiatriques héréditaires ou non
- **Anamnèse socioprofessionnelle et familiale** (soutien par l'entourage)
- **Antécédents médicaux et habitudes** (drogues, médicaments, alcool)

STATUS PSYCHIATRIQUE

Souligné : items importants

Rouge : items important pour l'anamnèse

En gras : items important la classification AMDP

IMPRESSION GÉNÉRALE

Observer :

- Corpulence, tenue vestimentaire :
 - Hygiène
 - Age apparent
 - Tenue soignée / négligée / neutre / excentrique
- Contact et relation :
 - Qualité de la relation instaurée par le patient : superficielle / bonne / mauvaise / froide / bizarre / inquiétante
 - Distance relationnelle instaurée par le patient : patient spontanée / patient ouvert / patient renfermé / patient désinhibé / patient envahissant / patient collant
 - Attitude du patient : patient collaborant / patient passif / patient soumis / patient séducteur / patient méfiant / patient agressif / patient puéril

PSYCHOMOTRICITÉ

Observer le tonus :

- Générale:
 - Ralentissement (inhibition, rigidité, catatonique)
 - Agitation (anxieuse, maniaque, confusionnelle)
 - Parakinésie (tics, tremblements, chorées, dyskinésie)
 - Crise (épileptique, hystérique)
- Visage : amimie, hypermimie, paramimie

TROUBLES COGNITIVES

- **Vigilance** et conscience : observation principalement
 - **Baisse de la vigilance** : degré variable d'endormissement, de ralentissement (de l'obnubilation au coma)
 - **Dissolution de la conscience** : perte de la capacité à comprendre le monde et à se comprendre soi-même, atteinte qualitative de la clarté de la pensée, perte de la capacité à faire des liens, à relier de manière censée
 - **Rétrécissement de la conscience** : focalisation de la pensée, de l'éprouvé et de la volonté sur un nombre réduit de thèmes
 - **Expansion de la conscience** : augmentation/intensification des sensations et des perceptions
 - « Avez-vous l'impression que votre perception est particulièrement intense ? Que vous êtes capable de percevoir les choses avec davantage d'acuité ? Que vous pouvez percevoir les couleurs avec davantage d'intensité ou d'entendre la musique plus fort ? »
 - > dépersonnalisation, troubles des perceptions
- **Orientation** : questions directes

« J'aimerais vous poser quelques questions qui pourront éventuellement vous paraître bizarres, mais je vous prie d'y répondre quand-même ».

 - **Temps** : « quelle date sommes-nous aujourd'hui ? Quand êtes-vous entrée dans la clinique ? »
 - **Espace** : « dans quelle ville nous trouvons-nous ? Pourriez-vous me dire où nous nous trouvons ici ? »
 - **Situation** : « que sommes-nous en train de faire ici ? Dans quel genre d'établissement nous trouvons-nous ici ? »
 - **Personne** : « pourriez-vous me donner la date et le lieu de votre naissance et adresse ? Quelle est votre âge/profession/nom ? »
- **Mémoire** et **attention** : observation (sauf si plainte du patient = examen détaillé)

« Maintenant, j'aimerais me faire une idée de votre capacité de concentration et voir avec vous comment votre mémoire fonctionne ».

 - **Troubles de l'aperception** : trouble de la compréhension des perceptions

« Pourriez-vous m'expliquer le proverbe suivant, qu'est-ce qu'il signifie : il n'y a que le premier pas qui coûte ? »
 - **Troubles de la concentration**

« Est-ce que vous arrivez à vous concentrer comme d'habitude ? Avez-vous de la peine à suivre une/cette conversation, à ne pas vous écarter du sujet ? »

« Pourriez-vous compter depuis 81 en déduisant chaque fois le chiffre 4 ? »
 - **Troubles de la fixation** : capacité à se souvenir de nouvelles informations au cours d'une période de moins de 10 minutes

« Est-ce que vous avez actuellement une bonne mémoire ? Avez-vous l'impression d'oublier davantage de choses ? »

« Seriez vous d'accord de faire un petit test de votre mémoire ? Veuillez retenir : **34, Oslo, cendrier**. Je vous les demanderai plus tard. »

- **Trouble de l'évocation** : capacité de se souvenir à long terme, à se souvenir de nouvelles information au cours d'une période de plus de 10 minutes
« Parlez-moi de votre passée/ scolarité / vie professionnelle. »
« Il y a quelques minutes je vous ai proposé 3 mots , est-ce que vous vous en souvenez encore? »
- **Confabulation** : récit imaginaire, spontané ou suggéré (mais vécu comme un souvenir propre) s'exprimant pour compenser une lacune mnésique
Si une question a suscité le doute, la répéter après 15 minutes et comparer la réponse
- **Paramnésie** (fausses impressions) /**hypermnésie** (augmentation de la capacité de mémorisation dans les états fiévreux ou toxiques ainsi que les chocs traumatiques)

LANGAGE

DISCOURS, EXPRESSION VERBALE

Observer :

- Le mode de langage :
 - Dialogue /monologue / soliloque (entretien avec soi-même)
 - Dialogue hallucinatoire / réticence / retenue / inhibition / mutisme
- La forme , le style:
 - Dysphonie : difficulté à émettre des sons et à parler
 - Réduction (diminution) du flux verbal
 - Adjonctions / transformations verbales / transformations phonémique
 - Marmonnements, chuchotements en dehors de la conversation

ELOCUTION

Observer :

- Le débit :
 - Brady/tachy-phémique
 - Laconique / loquace, logorrhéique
- Le ton :
 - Monocorde / exaltée

CONTENU

Observer :

- Incohérence du langage : distorsions grammaticales, pertes de connexion logique, inadéquations soudaines de vocabulaires, formulations grossièrement pédantes
- Fuites des idées
- Pauvreté de contenu du langage
- Réponses déroutantes, erronées

PENSÉE

COURS ET DÉSORGANISATION-DISSOCIATION DE LA PENSÉE

Question d'introduction : *qu'est-ce qui se passe ces temps avec votre faculté de penser ? Parvenez-vous à penser clairement ?*

Demander :

- ↓ de la pensée :
 - **Pensée inhibée** : frein et blocage de la pensée; penser est fatigant
« Avez-vous l'impression que le fait de penser vous fatigue plus que d'habitude ? Parfois on peut avoir l'impression que notre pensée se heurte à une résistance, est-ce que vous connaissez ce phénomène ? »
- ↑ de la pensée :
 - **Ruminations** : préoccupations incessantes, répétitives et désagréables gravitant autour d'un même thème
« Est-ce qu'il arrive que vous pensiez sans cesse à certaines choses ? Avez-vous des pensées qui tournent tout le temps dans votre tête ? Avez-vous tendance à ressasser toujours les mêmes choses ? »
 - **Idées envahissantes** : afflux pressant de multiples pensées
« Avez-vous l'impression d'avoir trop d'idées à la fois ? »

Observer :

- ↓ de la pensée :
 - **Pensée ralentie** : lenteur ou temps de latence dans le déroulement de la pensée
 - **Pensée rétrécie** : réduction de la pensée sur un nombre limité de sujets
« Pouvez-vous prêter attention facilement à des choses simples ? Est-ce que vos pensées ont tendance à être ralenties ou embrouillées ? »
 - **Persévération** verbale : répétition de mots ou de phrases
 - **Pensée circonstanciée** : discours minutieux (cohérence et le fil de la pensée préservés) chargée de détails inutile (difficulté à distinguer l'essentiel de l'accessoire)
 - **Réponses à côté** : perte du fil de la pensée avec des changements de buts. -> le patient n'arrive pas à terminer ses phrases parce que sa pensée est parasitée par d'autres idées. Il faut s'assurer que le patient a bien compris la question en lui demandant de la répéter.
 - **Pensée barrée** : suspension brusque du cours de la pensée
« Avez-vous parfois l'impression que le cours de votre pensée se perd ou qu'il s'interrompt ? »
- ↑ de la pensée :
 - **Fuite** des idées ou **pensée digressive**
« Avez-vous été capable de vous concentrer ces derniers temps ? »
 - **Néologismes** : utilisation de mots non compréhensibles ou nouvellement créés.
- - - - -> discontinuité de la pensée :
 - **Pensée incohérente** : perte de logique, pensée disloquée ou incompréhensible
 - Réponse à côté, coq à l'âne
 - Jeux de mots, calembours, mots assonancés, contamination
 - Ellipse (omettre un ou plusieurs éléments en principe nécessaires à la compréhension), relâchement associatif, condensation (« résumé de la pensée »)

CONTENU DE LA PENSÉE

Observer : les thématiques et les informations

- La capacité d'abstraction et de causalité :
 - Contenu asymbolique, alexithymique, rétrécie, rationnel
 - Contenu syncrétique (appréhension globale, floue, non structurée de la réalité), paralogique, morbide
 - Contenu magique
- Les idées délirantes
- Les idées obsédantes, les ruminations

DÉLIRE, TROUBLES DU MOI ET DES PERCEPTIONS

DÉLIRE

- Démarche :
 - Phrase- de départ :
Avez-vous vécu ces derniers temps des choses bizarres qui vous ont inquiété ou qui vous ont même fait peur ?
 - Chercher des indices : s'il y a un soupçon de symptômes délirants, il faut investiguer également leur contenu -> item : idées délirantes
 - Confrontation : pour vérifier si la conviction subjective (≠ questionnement critique) du patient est délirante ou non, il faut lui proposer des explications rationnelles alternatives et analyser sa réaction.
- Vécu prédélirant : demander
 - **Pressentiment délirant** : atmosphère bizarre ou anormale
Avez-vous l'intuition qu'il va vous arriver quelque chose, que tout est inquiétant, qu'il se trame quelque chose?
 - **Perception délirante** : attribution d'un sens erroné à une perception normale existante
Existe-t-il dans votre entourage des choses particulières qui ont une signification spéciales ou privée et qui ne concerne que vous ? Est-ce que tous les feux sont verts exprès pour vous ?
 - **Intuition délirante** : conviction délirante non rattachée à une perception existante/normale
« Est-ce que cette idées vous est venue subitement à l'esprit ou est-ce que vous la connaissez depuis longtemps ? Etes-vous convaincu de ne pas vous tromper ? »
- Vécu délirant : observer et demander
 - **Idées délirantes non systématisées**
 - **Systématisation du délire** : degré d'organisation du délire, liens entre les délires
« Voyez-vous un quelconque rapport/lien entre ces choses? Pourriez-vous me l'expliquer ? »
 - **Dynamisme du délire** : investissement affectif du délire
- Idées délirantes : À INVESTIGUER SI SOUPÇON DE DÉLIRE!!!
 - **Idées délirantes de référence** : les événements fortuits sont ramenés/interprétés en référence à soi
« Avez-vous l'impression que beaucoup de choses qui se passent autour de vous ont une signification qui vous concerne ? Est-ce que les déclarations, par exemple à la télévision, vous sont adressées personnellement ? Les gens font-ils des allusions à votre sujet ou tiennent-ils des propos à double sens ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas ce qu'ils semblent être ? »

- **Idées délirantes de préjudice ou de persécution :**
« Avez-vous l'impression que certaines personnes/quelqu'un vous en veulent/veut, que certaines personnes/quelqu'un ont/a l'intention de vous faire du mal ? Est-ce que l'on essaie délibérément de vous faire du mal ? Comment ? »
- **Idées délirantes de jalousie :**
« Avez-vous l'impression que votre partenaire ne vous est pas fidèle ? Qu'est-ce qui vous permet de le déduire ? Avez-vous des raisons d'être jaloux ? »
- **Idées délirantes de culpabilité :**
« Est-ce que vous vous sentez responsable de certaines choses ou certains actes ? Avez-vous le sentiment que vous vous êtes rendus coupable ? »
- **Idées délirantes de ruine :**
« Pourrez-vous me donner quelques renseignements sur vos revenus ? Est-ce que votre argent/moyen suffit pour vous nourrir, pour vous habiller et pour les autres choses dont vous pouvez avoir besoin ? »
- **Idées délirantes hypocondriaques :**
« Avez-vous peur d'être atteint d'une maladie grave que les médecins n'ont pas découverte ? Avez-vous l'impression que votre corps ne fonctionne pas de manière satisfaisante ? Pouvez-vous croire que vous êtes en bonne santé physique si les médecins vous le disent ? »
- **Idées délirantes de grandeur :**
« Avez-vous l'impression de disposer de facultés extraordinaires ? Avez-vous par exemple, l'impression d'être le fils ou la fille d'autres personnes que des parents que vous avez ? »
- **Autres contenus délirant :** délires fantastiques

TROUBLES DES PERCEPTIONS

- Démarche :
 - ATTENTION, il faut explorer prudemment et éviter les questions du type « est-ce que vous entendez des voix ? »
 - Demander
 - Question d'introduction :
« Y a-t-il quelque chose qui vous angoisse ou qui distrait ? »
« Y a-t-il quelque chose qui vous influence de façon déroutante ou inquiétante ? »
« Je voudrais vous poser une question de routine que je pose à tout le monde. est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des visions ou des expériences inhabituelles, comme en ont parfois certaines personnes ? »
- **Illusions** : représentation déformées correspondant à un stimulus réel (arbre mort le long d'une route au crépuscule perçu comme un individu menaçant) -> s'il y a des indices dans le discours du patient, lui demander des précisions
- **Hallucinations** : perception sans stimulus réel
 - Hallucination **acoustico-verbales** :
« Vous arrive-t-il parfois d'entendre parler quelqu'un, bien qu'il n'y ait personne dans les environs immédiats ? D'autres personnes l'entendent ? S'agit-il d'un homme, d'une femme, d'une voix familières ? Que vous dit-elle ? Est-il possible qu'il ne s'agisse que de vos propres pensées qui font écho en vous ? »
 - Hallucinations **auditives** :
« Vous est-il arrivé d'entendre autre chose ? Par exemple des bruits, des sons ? »
 - Hallucination **visuelles** :

« Vous est-il arrivé de voir des personnes ou des objets qu'autrui ne pouvait voir ? Pourriez-vous préciser ? »

- Hallucination **cénesthésiques** : perception de frôlement, de caresse ou de piqures, de brulures, de pincement douloureux
« Y a-t-il des choses bizarres qui se passent dans votre corps ? avez-vous l'impression que quelque chose dans votre corps a changé ? Si oui, comment vous en rendez-vous compte ? »
- Hallucination **olfactives** et **gustatives**
« Avez-vous senti des odeurs bizarres ces derniers temps ? Ou est-ce que la nourriture et les boissons ont un autre goût que d'habitude ? »
- Pseudo-hallucination

TROUBLES DU MOI

- Définition : altération de la manière de s'éprouver soi-même, les autres ou l'environnement, perte de familiarité
- Démarche :
 - ATTENTION, il est important d'explorer prudemment et précautionneusement les troubles du moi. Le patient peut ne pas en parler et se montrer méfiant, anxieux et fortement désécurisé par la mise en doute de son vécu.
 - Demander
 - Question d'introduction :
« Avez-vous par exemple observé ces derniers temps que vous ou votre entourage avez changé d'une manière quelconque ? J'aimerais vous demander si vous avez constaté un changement quelconque dans votre vécu ou dans votre entourage ? en quoi consiste ce changement ? Pourriez-vous le décrire ? »
- **Déréalisation** ou étrangeté : perte de familiarité par rapport à l'environnement
« Ces derniers temps, votre environnement habituel vous paraît-il déformé ou étrange ? Votre perception du monde / les couleurs / l'intensité de la musique que vous écoutez / les aliments a-t-elle changé ? »
- **Dépersonnalisation** : perte de familiarité par rapport à soi, sentiment de ne plus être soi-même
« Percevez-vous votre corps comme d'habitude ? Avez-vous la sensation que votre corps s'est physiquement transformé ? Avez-vous l'impression d'avoir complètement changé, de ne plus être la même personne qu'avant ? »
- **Dévinement de la pensée** : d'autres personnes participent dans l'élaboration des pensées du patient ou bien savent ce que le patient pense. Les pensées n'appartiennent plus au patient.
« Croyez-vous qu'autrui connaît vos pensées ? Qu'autrui peut savoir ce que vous êtes en train de penser ? Pouvez-vous me donner un exemple ? »
- **Vol de la pensée** : pensées enlevées ou prélevées
« Avez-vous l'impression qu'on peut vous prendre vos pensées ? »
- **Pensées imposées** : pensées influencées, gouvernées, suggérées par l'extérieur
« Avez-vous parfois le sentiment que vos pensées ne vous appartiennent pas, que vos pensées sont induites de l'extérieur ? Avez-vous l'impression qu'on influence et qu'on dirige vos pensées ? »
- **Autres expériences d'influence** : sentiments, décisions imposées par l'extérieur
« Il y a des personnes qui ont parfois le sentiment d'être hypnotisées ou quasiment téléguidées, est-ce que vous connaissez également ce sentiment ? Pouvez-vous me donner un exemple ? »

AFFECTS (ÉMOTIONS OBSERVÉES) ET TROUBLES AFFECTIFS

AFFECTS

- **Thymie** : demander
 - Humeur abaissée/élevée/neutre
« Comment définiriez votre humeur ? Vous vous sentez plutôt triste, heureux, sans changements ? »
 - Humeur :
 - Apathique, triste, anesthésiée
 - Joyeuse, euphorique, exaltée, avec un sentiment de puissance
 - Anxieuse, angoissée, apeurée
 - Colérique, agressive, méfiante
 - Avec un sentiment de culpabilité
- Symptômes d'accompagnement : demander
 - **Anhédonie** : « est-ce que vous avez moins de plaisir à faire les choses ? »
 - Perte **d'appétit** : « avez-vous eu bon appétit ces derniers temps ? »
 - Trouble du **sommeil** : « avez-vous eu des difficultés à vous endormir ce mois dernier ? Vous réveillez-vous trop tôt le matin ? »
 - Manque d'énergie : « avez-vous l'impression de manquer d'énergie, d'être plus lent dans vos mouvements ? »
 - Libido abaissée : « avez-vous constaté un changement dans vos intérêts sexuels ? »
- **Modulation** : observer
 - Affects congruents à l'humeur / discordance affective
 - Labilité affective

TROUBLES AFFECTIFS ET ANXIÉTÉ

- **Perplexité** : difficulté à se situer par rapport aux événements sur le plan affectif
« J'ai l'impression que vous avez perdu la vue d'ensemble de la situation, est-ce vrai ? J'ai actuellement l'impression que vous ne savez pas tout à fait ce qui se passe, est-ce vrai ? »
- **Anesthésie affective** : demander et observer !
« Est-ce que votre vie affective a changé d'une manière ou d'une autre ? Etes-vous encore capable d'être triste ou de vous réjouir ? Ou vous avez plutôt le sentiment d'être vide /mort intérieurement ? »
- **Trouble de l'éprouvé vital** : diminution de la vitalité, de l'élan, de la force physique et psychique
« Avez-vous la sensation d'une diminution de votre vitalité, de votre élan et de votre fraîcheur ? Avez-vous une impression d'abattement, de faiblesse, de fatigue ? »
- **Humeur déprimée** : humeur de tonalité négative, déprimé, abattu
« Comment vous sentez-vous actuellement ? Comment pourriez-vous décrire votre humeur actuelle ? Etes-vous triste ? »
- **Perte de l'espoir** : pessimisme, incapacité à se projeter dans l'avenir
« Quelles sont vos réflexions lorsque vous pensez à votre avenir ? Quelle est votre attitude à l'égard de l'avenir ? Pouvez-vous imaginer que tout va s'arranger ? Quand vous vous tournez vers l'avenir, croyez-vous que votre état s'améliorera ? »
- **Anxiété psychique éprouvée** : peur sans pouvoir dire quoi
« Vous inquiétez-vous en ce moment plus que d'habitude ? Pouvez-vous me donner un exemple ? Avez-vous peur parce que vous craignez qu'un malheur arrive ? »
- **Euphorie** : humeur de tonalité positive, bien-être excessif
« J'ai l'impression que vous êtes spécialement de bonne humeur aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ? »
- **Dysphorie** : mauvaise humeur, agacement, grincheux, bougon
« J'ai l'impression que vous êtes de mauvaise humeur. Est-ce que c'est vrai ? »

- **Irritabilité** : excitabilité, tension forte
« Je ressens actuellement une certaine irritation chez vous, est-ce que c'est vrai ? »
- **Agitation intérieure** : fébrilité intérieure, nervosité
« Pourriez-vous me décrire comment vous vous sentez intérieurement ? Vous sentez-vous agité intérieurement ? »
- **Propension à se plaindre** : lamentation
- **Sentiment d'insuffisance**
« Comment jugez-vous vos propres capacités ? Avez-vous l'impression que vous valez moins qu'autrui/ de ne rien valoir/d'être incapable et stupide ? »
- **Augmentation de l'autosatisfaction**
« Avez-vous un sentiment particulier de force et d'augmentation de vos performances ? »
- **Sentiment de culpabilité**
« Il arrive parfois que des patients se sentent tout à coup coupables de certains événements qui se sont passés il y a déjà bien des années et pour cette raison ils ont une mauvaise conscience. Cela vous arrive-t-il également ? de quelle nature sont-ils ? »
- **Sentiment de ruine** : crainte de ne pas disposer de moyens suffisants pour subvenir à son existence
« Avez-vous peur qu'il vous manque les moyens de subvenir à votre existence ? »
- **Ambivalence affective** : coexistence pénible de plusieurs sentiments et représentations contradictoires
« Vous arrive-t-il de vivre des sentiments contradictoires simultanément ou que des pensées contradictoires coexistent en vous ? »
- **Discordance affective** ou parathymie : affects paradoxaux inadéquats
- **Labilité affective** : changement émotionnels rapides, instabilité psychique
- **Incontinence affective** : émergence d'émotions incontrôlables voire disproportionnées
- **Monotonie affective** : réduction de la capacité à moduler, à faire osciller ses affects.

TROUBLES ANXIEUX (PHOBIES, OBSESSIONS, IMPULSIONS, COMPULSIONS)

- **Méfiance non délirante** : attitude soupçonneuse tantôt anxieuse, tantôt hostile avec une tendance à douter de la bonne foi des autres
« Ressentez-vous ces derniers temps une certaine méfiance vis-à-vis autrui ? Par le passé, vous décririez-vous comme plutôt une personne méfiante que crédule ? »
- **Hypocondrie non délirante** : angoisse/crainte non fondée d'avoir ou de contracter une maladie
« Avez-vous peur d'être atteint d'une maladie grave ? Avez-vous l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps ? avez-vous déjà fait des démarches pour trouver ce qui ne fonctionne pas ? »
- **Phobies** : peur de certaines situations, objets, animaux admise comme irrationnelles qui donnent lieu à des conduites d'évitement
« Vous arrive-t-il de prendre peur, voire même de paniquer face à certaines situations concrètes ? tentez-vous de les éviter ? »
- **Obsessions** : idées qui s'imposent de manière répétée et qui sont vécues comme absurdes et contre sa propre volonté
« Est-ce que vous avez des idées particulières qui s'imposent à vous de façon automatique et qui tournent tout le temps dans votre tête (et qui vous paraissent irrationnelles) ? »
- **Obsessions-impulsions** : idées qui s'imposent et poussent à des actes bien définis
« Ressentez-vous des pulsions répétitives à exécuter des actes particuliers et craignez-vous de les accomplir une fois ? Vous sentez-vous poussé à répéter continuellement certains gestes ou actes particuliers ? »
- **Compulsions** : conduites (actions) sous l'effet d'impulsions internes

« Vous sentez-vous forcé de répéter sans cesse certaines actions, bien quelles vous paraissent irrationnelles ? »

TROUBLES SOMATIQUES ET DU DYNAMISME

« Maintenant, j'aimerais vous demander comment vous jugez votre élan et votre initiative à faire certaines choses. ».

- **Diminution du dynamisme ou de l'entrain/vitalité** : manque d'énergie, d'entrain
- **Inhibition du dynamisme** (frein) :
- **Augmentation du dynamisme**
- **Agitation motrice**
- **Parakinésie** : anomalies qualitatives des mouvements complexes
- **Maniérisme** ou bizarreries : gestes et actes quotidiens apparaissant comme bizarres, sugrenus artificiels ou prétentieux
- **Théâtralisme** : impression que le patient se donne lui-même en représentation
- **Laconisme** : parcimonie verbale
- **Logorrhée** : augmentation du flux verbal

IDÉES SUICIDAIRES ET HÉTÉRO-AGRESSIVITÉ

- Attention, NE PAS EVALUER LA SUICIDALITE EST CONSIDERE COMME UNE FAUTE MEDICO-LEGALE!
- Question explicites :
 - « Est-ce que vous avez par moments des idées noires ou des envie de vous faire du mal ? »
 - « Est-ce que cela vous arrive d'avoir envie de mourir ? »
 - « Avez-vous déjà pensé à vous suicider ? »
- Critères de gravité à évaluer
 - Facteur de risque épidémiologique à dépister :
 - Antécédents de tentatives ;
 - Sexe masculin ;
 - Trouble psychiatrique ;
 - Dépendance ;
 - Isolement social et familial ;
 - Evénements de vie négatifs ;
 - Maladie chronique ;
 - Affection somatique invalidante.
 - Urgence si :
 - Elaboration d'un scénario suicidaire ;
 - Les idées suicidaires sont envahissantes ;
 - Planification dans le temps du geste suicidaire.
 - Danger si :
 - Le moyen est accessible ;
 - Le moyen est très létale.

EXAMEN ORL

ANAMNÈSE ORL

- Oreille :
 - Otalgie
 - Otorrée
 - Acouphènes
 - Hypoacousie
 - Vertiges
- Nez :
 - Rhinorrhée
 - Epistaxis
 - Odorat : hyposmie, anosmie, cacosmie
 - Obstruction nasale
 - Douleurs sinusale
- Bouche, pharynx, larynx :
 - Dysphagie (trouble de la déglutition)
 - Odynophagie (douleur pharyngée ou œsophagienne lors de la déglutition)?
 - Dysphonie
 - Fausses routes
 - Tuméfactions du cou

STATUS ORL

Position de médecin :

- Assis face à face
- Jambes de part et d'autre de celles de la patiente

PALPATION CERVICALE

1. Chaines jugulaires interne et externe (ou spinale) : le patient incline la tête pour détendre le muscle, le médecin saisit le muscle SCM
2. Chaines sous-mentonnière et sous-mandibulaire: palper avec les doigts sous la mandibule (pour distinguer un ganglion d'une glande, il suffit de glisser la masse vers l'extérieur ; un ganglion est mobile pas une glandes)
3. Chaîne spinale : derrière le SCM
4. Chaîne sus-claviculaire
5. Thyroïde

Chaines jugulaires internes



Chaines sous-mentonnières



Chaines jugulaires internes et spinales



Chaines spinales



Chaines sous-mandibulaires



Chaines sus-claviculaires



INSPECTION BUCCALE

Utiliser un abaisse-langue : saisir comme un crayon

1. Ouverture de la bouche : supérieur ou égale à 35mm
2. Mobilité de la langue
3. Dessous de la langue : canal de Wharton (compression des glandes sous-linguales permet la libération de salive) et veines linguales
4. Sillon gengivo-lingual et sillon gengivo-glosse sur les 4 cadrans :
 - Evaluation de l'état dentaire et parodontal dans le même temps
 - Canal de Sténon :
 - Orifice situé entre les 2-3e molaires supérieures.
 - La palpation des glandes protides produit une libération de salive.
5. Oropharynx
 - Positionner l'abaisse-langue sur le V lingual
 - Visualiser les amygdales palatines et le sillon amygdalo-glosse (séparant la loge amygdalienne de la base de la langue)
 - Evaluer la mobilité et la contractilité du voile du palais en demandant au/à la patient-e de dire « ah ah ah ah ah ».
 - Visualiser les sillons gingivoglosse et rétromolaire en s'aidant d'un 2ième abaisse langue.



Canaux de Wharton



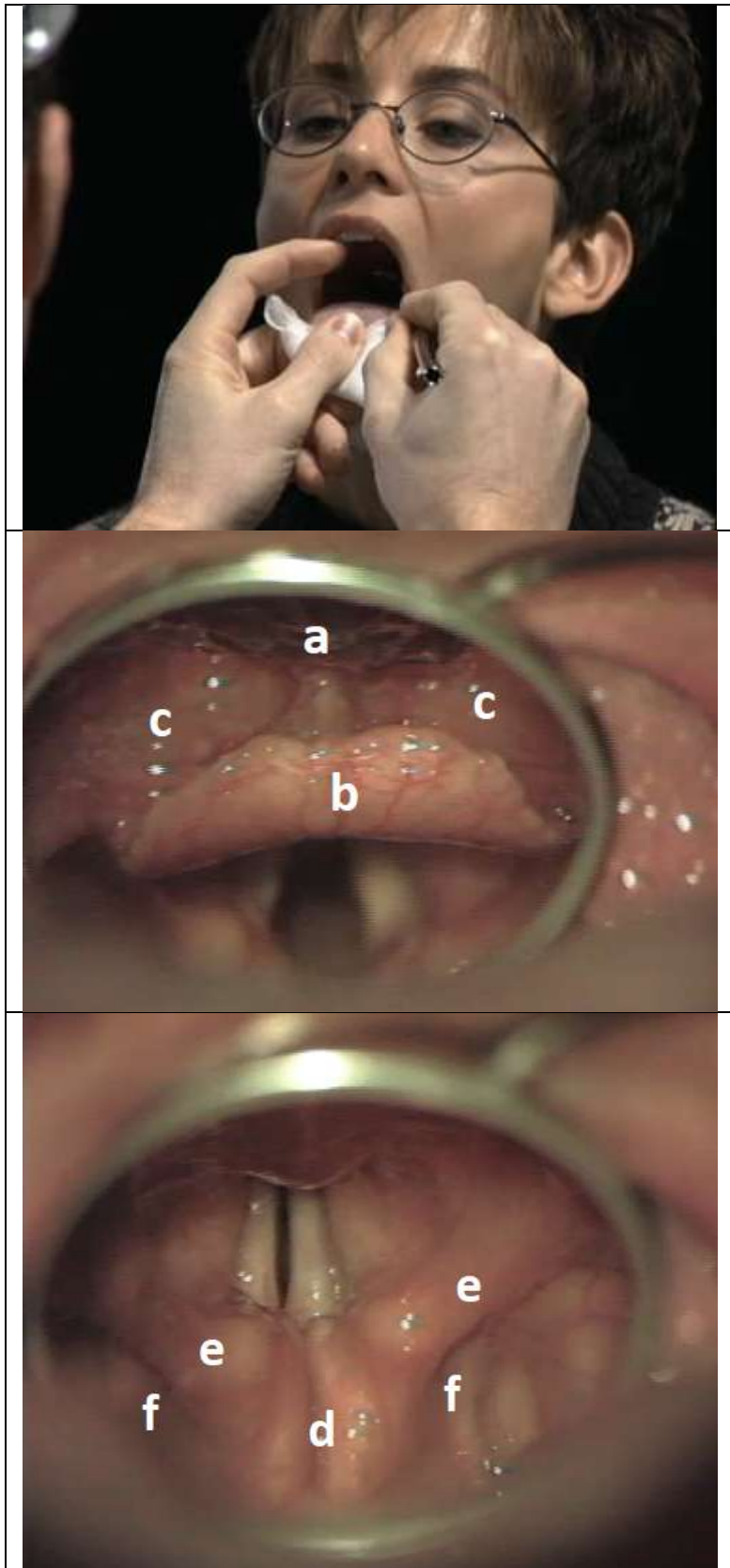
Orifice des canaux de Sténon



Sillons gingivoglosse et rétromolaire

LARYNGOSCOPIE INDIRECTE

- Préparation à l'utilisation du miroir :
 - Saisir la langue avec une compresse et la sortir de la bouche.
 - Préchauffer le miroir sur le chauffe-miroir pour éviter la buée et tester la température sur le dos de la main.
 - Demander au patient de respirer pour ouvrir le fond de la bouche.
 - Introduire du miroir dans la cavité buccale en restant parallèle à la langue
- Visualisation et évaluation :
 - a) Base de langue
 - b) Epiglotte
 - c) Valécules
- Demander de dire un « iiiiiiiiii » ce qui provoque l'ascension du larynx, la fermeture glottique et l'exposition des cordes vocales.
- Visualisation et évaluation :
 - d) Margelle laryngée
 - e) Aryténoïdes
 - f) Sinus Piriformes



INSPECTION DU NEZ

- Préparation :
 - Demander au patient de baisser la tête.
 - Utiliser un spéculum de Killian qu'il faut saisir avec le pouce et le majeur.
 - L'index, dirigé au dessus de la tête du spéculum, est placé sur la pointe du nez et sert à stabiliser l'inspection.
- Observation:
 - Vestibule : soulever la pointe du nez et rechercher une déviation septale antérieure
 - Forme du nez, état des pyramides
 - Valves nasales : recherche d'un collapsus à l'inspiration
- Perméabilité :
 - Placer un miroir sous le nez et comparer la condensation sur un miroir ou bien fermer une narine et demander d'expirer par le nez
- Visualisation :
 - Cornet inférieur : taille (obstruction) et couleur de la muqueuse (normalement rose)
 - Méat inférieur :écoulements
 - Polypes ?
- Rhinopharynx:
 - Utilisation du miroir de Michel : demander au patient de respirer par le nez, comprimer la langue vers le bas à l'aide d'un abaisse langue puis après avoir préchauffer le miroir le glisser vers le fond et lever le miroir après avoir traversé la luette.
 - Visualiser :
 - Septum
 - Muqueuse septale postérieure
 - Queue du cornet moyen



Cornet inférieur



Méat inférieur



Septum



Muqueuse septale postérieure



Queue du cornet moyen

INSPECTION DE L'OREILLE

- Repérage des structures osseuses péri-auriculaires
 - Arcade zygomatique, l'articulation temporo-mandibulaire (paroi osseuse antérieure du CAE), l'angle mandibulaire, la pointe de la mastoïde en arrière et le reste de la mastoïde en réclinant le pavillon vers l'avant
- Percussion du planum mastoïdien à la recherche d'une douleur
- Otoscopie :
 - Préparation :
 - La tête du patient tournée à l'opposé de l'examineur puis inclinée sur l'épaule (le patient regarde vers le bas).
 - Le pavillon est tiré en arrière et en haut.
 - Evaluation du CAE
 - Tympan
 - 4 cadrants
 - Marteau avec l'Umbo (extrémité inférieure du manche) et le processus Brevis (supérieur, en avant de membrane Pars flaccida)
 - Test de Valsalva + test de Toynbee : atteste de la perméabilité tubaire
- Acoumétrie phonique et instrumentale
 - Voix chuchotée : trentre trois
 - Rinné : + ou –
 - Weber : latéralisé ou centré

COMPLÉMENT : EXAMEN OTO-NEUROLOGIQUE

1. Inspection des oreilles à l'aide d'un otoscope.
2. Test de Weber de Riné (vous entendez partout ?)
3. Test des NC III, IV et VI -> 4 cadrans
4. Test accommodation- convergence
5. Sensibilité de la face
6. Sourire, fermer les yeux, froncer les sourcils, lever les épaules
7. Bouger la langue
8. Toucher la pointe du nez (une fois les yeux ouverts, une autre fois les yeux fermés)
9. Tourner avec le patient : inhibition du nystagmus car fixation sur le nez.
10. Marionnettes
11. Test de Romberg
12. Marcher sur place (les yeux fermés ; si déficit vestibulaire : tourne de côté)
13. Marcher sur les talons et la pointe des pieds
14. Mettre des lunettes obscures et chercher un nystagmus (secouer la tête avec les mains)
15. Hallpike (avec lunettes, tourner la tête de coté à 45 degrés) (teste les canaux semi-circulaires postérieurs).
16. Halmagyi : à 30 degrés (patient couché avec lunettes obscures, tourner la tête rapidement de coté à 30 degrés pour tester le canal semi-circulaire latéral).

EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

ANAMNÈSE

- Plaintes spontanées
- Grossesse
- Seins (toujours demander si c'est bilatéral):
 - Présence d'une masse d'une boule?
 - Présence d'un écoulement?
 - Présence d'une rougeur?
 - Antécédents personnels concernant les seins (tumeur et mammographie)
 - Histoire familiale de cancer de seins
- Cycle menstruel:
 - Date des dernières règles
 - Régularité des cycles menstruels

STATUS GYNÉCOLOGIQUE

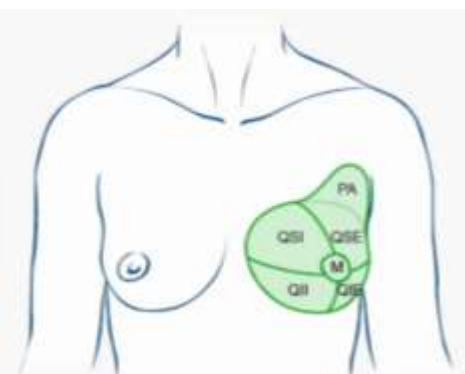
- Demander à la patiente d'enlever son haut et son soutien-gorge afin de dénuder le buste.

EN POSITION ASSISE

- Demander à la patiente de s'asseoir sur la table d'examen et de ne pas bouger.
Demander à la patiente de laisser pendre ses bras le long du corps et de placer ses mains sur ses cuisses afin que la musculature soit détendue.
- Inspecter les seins:
 - Vue globale de la cage thoracique:
 - Observer le thorax: thorax en carène ou en entonnoir, séquelles d'accidents
 - Plaques aérolo-mamellaires supplémentaire: fréquentes
 - Symétrie et morphologie
 - Comparaison du volume :
 - Anisomastie idiopathique : différence physiologique de taille des deux seins.
 - Amastie : développement inexistant
 - Contours :
 - Réguliers et symétrique
 - Rechercher des bosses, des voussures, des ronflements, des aplatissement, des dépression, des rétractions.
 - Peau:
 - Couleur: une rougeur
 - Inflammatoire: seins lourds, tendu et chaude
 - Infectieuse: abcès circonscrit
 - Cancéreuse: lésion étendue et nécrose
 - Texture :

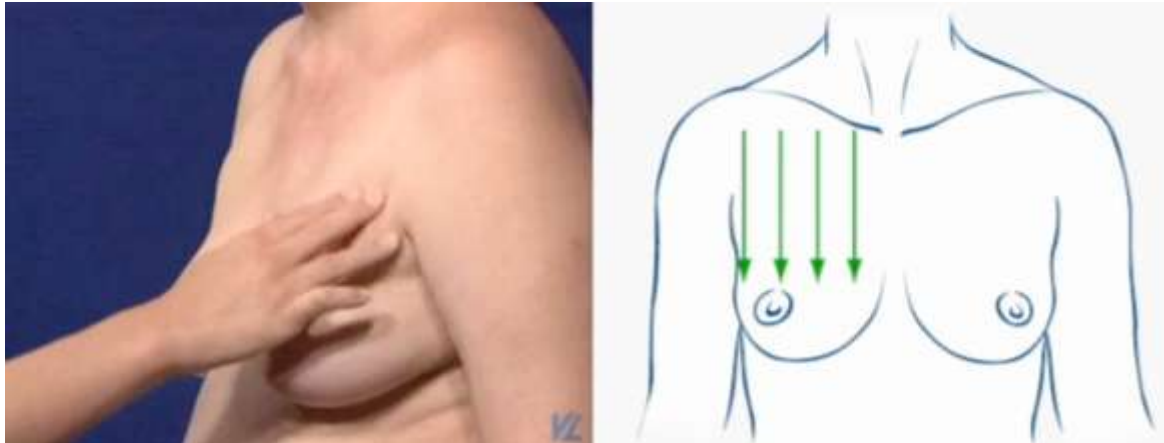


- Vergeture: physiologique
 - Peau d'orange (rigide, pictée, capitonée, ferme): lympho-oedème d'origine cancéreux
 - Cicatrices : à corrélérer avec les antécédents
 - Réseaux veineux : dessin des veines indique une stase
 - Présence de Naevius
 - Mamelons surnuméraires
- Mamelons et l'aréoles: (comparer entre les deux seins)
 - Asymétrie
 - Rétraction: si récente, affection maligne
 - Ecoulement: si unilatéral, affection maligne
 - Qualité de la peau: changement de couleur ou de texture
- Inspecter la mobilité:
 - *Demander à la patiente de lever les bras et placer les mains derrière la nuque.*
 - Observer la mobilité des seins à la recherche d'une voussure ou une rétraction cutané.
- Inspecter sous traction musculaire :
 - *Demander à la patiente de mettre ses mains sur ses hanches et pousser la poitrine en avant. Dans cette position, les muscles pectoraux sont tendus et fixés, ce qui peut mettre en évidence d'autres déformations du sein.*
 - Observer
- Palpation en position assise :
 - Diviser le sein en 4 cadrans virtuels:
 - Cadran supéro-externe prolongé par un prolongement axillaire
 - Cadran inféro-interne
 - Cadran inféro-externe
 - Cadran supéro-interne



- Utiliser la pulpe des trois doigts du milieu

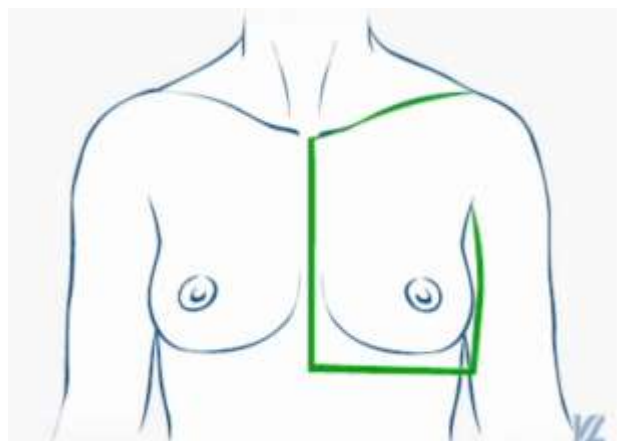
- Palper:
 - -> les cadrans supérieurs (plus facilement palpables car leur peau est fine)
 - -> de gauche à droite
 - -> partir de la clavicule (pour palper le tissu glandulaire épars)
 - -> de haut en bas
 - -> en suivant des lignes verticale virtuelles parallèles



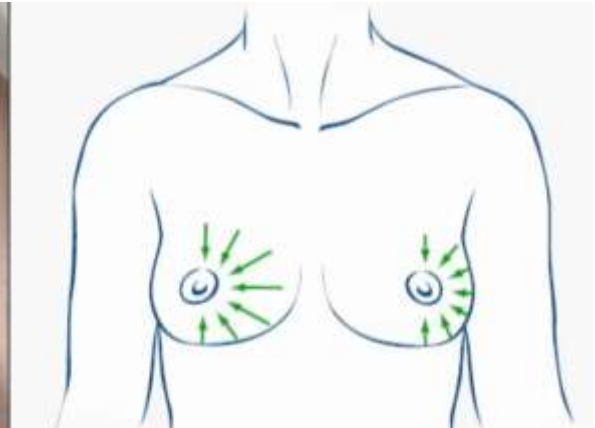
EN POSITION COUCHÉE

En position couchée, la partie inférieure du sein est mieux visible et palpable.

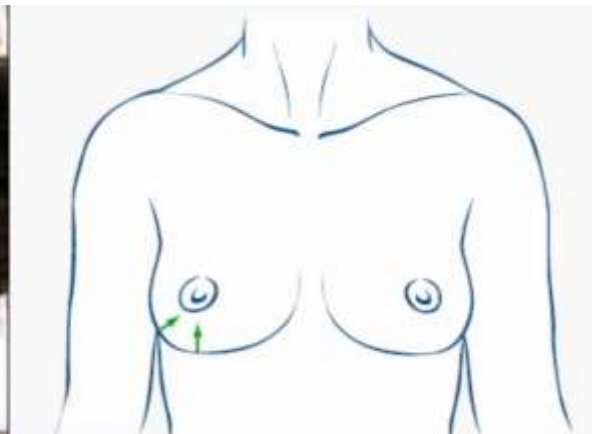
- Inspection :
 - Inspecter en position couchée en faisant attention aux cadrans inférieurs qui sont mieux visibles.
- Palpation:
 - Palper les régions délimitées par:
 - Le sternum
 - La clavicule
 - La zone axillaire postérieure
 - Une ligne virtuelle horizontale à 1 cm en-dessous du plis mammaire
 - Palpation par des mouvements centripètes:
 - Avec les trois doigts du milieu.
 - En réalisant des mouvements centripètes
 - Les moitiés des seins opposées au côté où se trouve l'examineur.



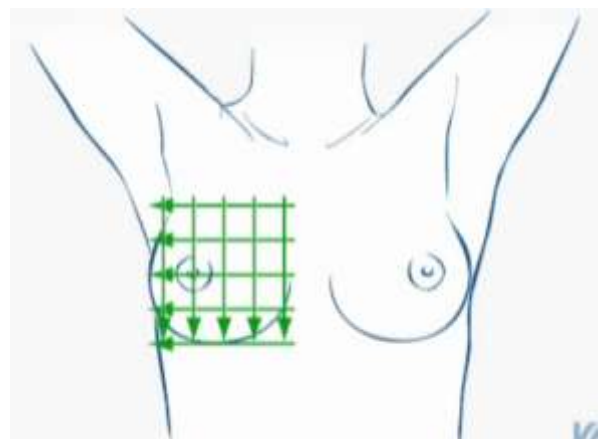
- Si l'examineur est à droite de la patient, palper le bord gauche des sein gauche et du sein droit, en commençant à 12 heure jusqu'à 6 heure.



- Changer de côté.
- Si l'examineur est à gauche de la patiente, palper le bord droit des sein gauche et du sein droit, en commençant à 6h jusqu'à 12 heure.



- Palpation par des mouvements en quadrillage:
 - Avec les trois doigts du milieu.
 - En réalisant des mouvements rectilignes.
 - D'abord transversaux puis en direction cranio-caudale et plus en profondeur.





- Recherche d'un écoulement:
 - **Informez la patiente**
 - Prendre le mamelon entre le pouce et l'index et comprimez le doucement
 - **Préférable: demander à la patiente de le faire.**
 - Observer la présence d'un écoulement.
- Description des ganglions.
 - Localisation
 - Nombres de ganglions touché
 - Taille
 - Consistance
 - Sensibilité
 - Mobilisation



PALPATION DES GANGLIONS LYMPHATIQUES

- Inspection :
 - Observer la région claviculaire:
 - Symétrie des structures
 - Netteté des contours
- Palpation des ganglions péri-vasculaires :
 - Demander à la patiente d'incliner la tête vers le côté à examiner pour détendre le SCM.
 - Poser une main sur l'épaule du côté opposée à celui examiné afin de prendre appui et stabiliser la patiente.
 - Palper l'aire entre la clavicule et les aisselles, le sein et le sternum.
 - Effectuer le même examen de l'autre côté.
- Palpation des ganglions axillaires :
 - Demander à la patiente de poser ses mains sur ses hanches sans exercer de pression afin de détendre les muscles de la région axillaires.



- Palper avec la pulpe des doigts:
 - Entrer depuis devant, derrière le bord externe du muscle grand pectoral.
 - Progresser en direction du creux.
 - La paroi postérieure (il est possible de réaliser cette palpation depuis le dos)
 - Effectuer l'examen de l'autre côté.
- Palpation en position couchée:
 - Demander à la patiente de laisser tomber les bras afin qu'ils soient détendus.
 - Pour examiner le côté droit, saisissez le côté droit de la patiente avec le bras droit, écartez-le et maintenez-le en abduction.
 - Palper des deux côtés.



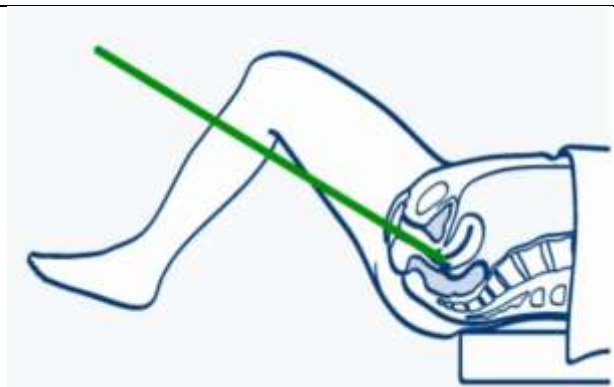
EXAMEN OBSTRÉTIQUE

PRÉPARATION À L'EXAMEN

- Préparer le matériel (stérile si la femme est enceinte).
- Préparer la chaise gynécologique : propreté, confort.

INSTALLER LA PATIENTE

- S'assurer que la patiente n'a pas de prolapsus ou d'incontinence.
- S'assurer que la patiente a vidé sa vessie.
- Inviter la patiente à se déshabiller en dessous de la taille.
- Inviter la patiente à s'asseoir sur la chaise gynécologique (les fesses doivent dépasser le bord de la chaise et à positionner ses jambes (détendues) sur les cales. Les bras doivent être positionnés le long du corps afin que la musculature abdominale ne soit pas contractée.
- Informer à l'avance de chaque étape et préciser ce qu'elle va ressentir.



Importance d'un bon positionnement:

En position correcte, les fesses dépassent le bord de la chaise et l'appui se répartit entre le sacrum et les vertèbres lombaires, entraînant ainsi un effacement de la lordose lombaire. Ainsi le bassin et son contenu sont basculés de manière à aligner le vagin avec l'axe visuel.

En position incorrecte, la patiente s'appuie sur son sacrum et maintient sa lordose lombaire. Le vagin n'est pas aligné avec l'axe visuel.

INSPECTION ET PALPATION ABDOMINALE

- Observer la présence d'une cicatrice (d'une ancienne césarienne).
- Palpation abdominale (commencer au-dessous des côtes car une masse ovarienne peut se situer très haut) à la recherche :
 - D'une masse abdominale
 - D'un globe vésical
 - D'un péritonisme
- Palpation rénale à la recherche d'une douleur des loges rénales
- Palpation des ganglions inguinaux à la recherche d'une adénopathie (petits ganglions = normal)



INSPECTION DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

- Préparation:
 - Mettre des gants (stériles si la patiente est enceinte)
 - Demander à la patiente d'écarter les cuisses
 - Toucher la cuisse avec le dos de la main pour savoir si la patiente est détendue et constitue un premier contact avant l'inspection.



- Inspection de :



La région pubienne



Les régions inguinales (au-dessus de la symphyse pubienne)



La région anale



Le périnée



La vulve

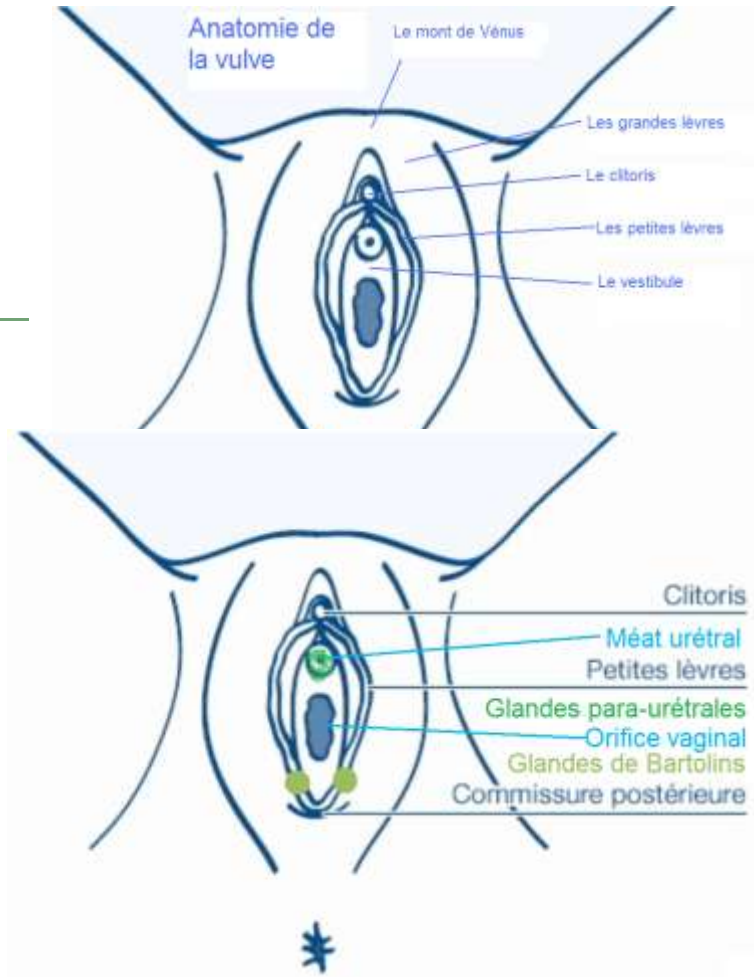


Le vestibule

- Inspection générale :
 - La peau à la recherche: d'abcès, de furoncles, de rougeurs ou d'éruptions cutanées)
 - La pilosité (forme et démangeaisons (poux du pubis ou morpions)

INSPECTION DE LA VULVE

- Evaluer :
 - La symétrie et la taille (des grandes lèvres et du clitoris)
 - Qualité de la peau et la pigmentation
 - La présence de lésions cutanées, de rougeurs, de tuméfactions, de lésions cutanées



- Anatomie :
 - Délimitations:
 - Antéropostérieures : clitoris <-> commissure postérieure
 - Latérales : petites lèvres
 - Contenu:
 - Méat urétral
 - Glandes para-urétrales
 - Orifice vaginal
 - Orifices des glandes de Bartholin
- Écarter les grandes lèvres au milieu de la vulve et les repousser à l'aide de l'index et du majeur en direction craniale.



- Inspecter :
 - Les petites lèvres:
 - Normal : asymétrique, taille variable et présence de glandes sébacées (papules blanches-jaunâtres)
 - Rechercher:
 - Des lésions, des cicatrices, des ulcérations et des différences de couleurs de la muqueuse
 - Des masses et condylomes
 - Le clitoris:
 - Normal: taille de 3-4 mm
 - Rechercher:
 - Des lésions et des ulcérations
 - Taille excessive
 - Le méat urinaire:
 - Normal: sailli en post-ménopause
 - Rechercher du pus ou des signes d'inflammation
- Écarter les grandes lèvres en position sacrale, c'est-à-dire par le bas.
- Inspecter l'ouverture du vagin:
 - Observer les caroncules: restes de l'hymen
 - Rechercher:
 - Lésions des caroncules
 - Une masse ou un signe d'inflammation
 - Un écoulement
- Inspecter la zone autour de la commissure postérieure à la recherche d'une cicatrice (restes d'épisiotomie)
- Inspecter le vestibule sous pression intra-abdominale en position sacrale:
 - Demander à la patiente de pousser comme si elle allait à selles en maintenant son souffle (manœuvre de Valsalva)
 - Rechercher des hernies et des prolapsus (responsable de pertes d'urine entre autre):
 - Hernie vésicale ou urétrale: urétro-cystocèle
 - Prolapsus utérin
 - Hernie intestinal et un prolapsus rectal: entérocele, rectocèle, polypes
 - Attention : l'examen visuel peut être trompeur ! Contrôlez par la palpation avec le doigt.



INSPECTION DE LA RÉGION ANALE

- Rechercher:
 - Masses
 - Cicatrices
 - Fissures
 - Fistules
 - Rougeurs
 - Hémorroïdes

INSPECTION DES GLANDES

- Palpation des glandes para-urétrales en cas d'urétrite:

- Prévenir le patiente de l'introduction de l'index dans le vagin.
- Écarter les grandes lèvres.
- Introduire, dans l'orifice vaginale, l'index (deux phalanges distales) vers

le bas pour éviter la friction avec l'urètre (très sensible).

- Tourner le doigt vers le haut.
- Appuyer délicatement vers le haut.
- Retirer le doigt en maintenant une légère pression sur l'urètre afin d'en exprimer son contenu.



Examen en supination, la pulpe de l'index vers le haut



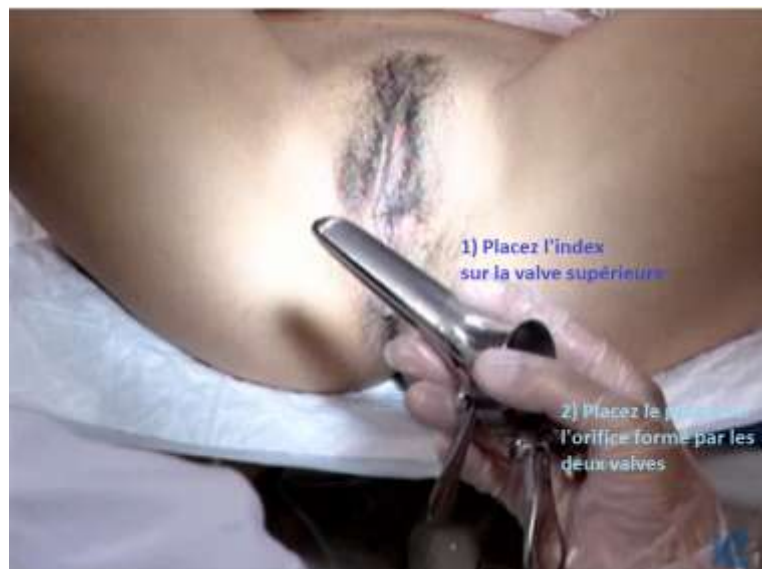
- Palpation des glandes vulvo-vaginales (glandes de Bartholin):

- Prévenir la patiente que l'on va introduire le doigt dans le vagin.
- Placer l'index dans l'orifice vaginal et le pouce sur la grande lèvre (main gauche pour le côté gauche et main droite pour le côté droit).
- Parcourir la grande lèvre avec le pouce en pinçant délicatement à la recherche d'une zone douloureuse ou une tuméfaction. Toute glande palpable est un signe pathologique.



EXAMEN AU SPÉCULUM

- Préparation :
 - Choisir le matériel
 - Un spéculum à conserver dans l'armoire chauffante. Il faut choisir la bonne taille
 - Un flacon de lubrifiant hydrosoluble
 - Une paire de gants non stérilisés
 - Étaler du lubrifiant à l'extrémité distale du spéculum.
- Mise en place du spéculum :
 - Saisir le spéculum avec la main gauche ou la main droite en fonction de la latéralité de l'examineur.



Écarter les grandes lèvres en tirant vers le bas (pour éviter une traction trop forte sur les régions sous-urétrales et clitoridienne) avec l'autre main.



- Tourner le manche du spéculum de 45° et l'apposer sur la commissure postérieure afin d'éviter toucher les régions urétrales et clitoridienne.

- Glisser le spéculum vers l'intérieur en le tournant de 45° et en maintenant une pression sur la paroi postérieure.
- Ouvrir les lames du spéculum afin de les placer devant et derrière le col: manœuvrer jusqu'à ce que le col soit visible sans toucher le (ce qui provoquerait des saignements).
- Maintenir les valves ouvertes grâce à l'écrou.
- Inspecter le col:
 - La position et l'axe (centré)
 - La forme (rond)
 - Le diamètre (2.5 cm)
 - La texture et la couleur de la surface (lisse et rose)
 - La forme de l'ouverture (ronde si nullipare et ovale ou en fente après grossesse)
- Faire un prélèvement
 - Quand faire le prélèvement?
Si suspicion d'infection génitale basse et présence d'un écoulement ou une douleur brûlante ou un prurit.
 - Introduire la spatule d'Ayre entre les lames du spéculum
 - Prélever du matériel dans le cul-de-sac postérieur du vagin.
- Inspecter le vagin lors du retrait du spéculum
 - Dévisser l'écrou tout en maintenant les lames écartées.
 - Retirer lentement le spéculum.
 - Rechercher:
 - Des ulcérations
 - Des kystes
 - Des fistules



PALPATION VAGINALE BIMANUELLE (PERMET D'EXAMINER L'UTÉRUS)

- Préparation:
 - L'examineur est debout.
 - Se munir de gant.
 - Utiliser la main préférentielle: replier le petit doigt et l'annulaire et écarter le pouce. Lubrifier les doigts restant.
 - Écarter les grandes lèvres en tirant vers le bas avec l'autre main.
 - Poser les doigts (index et majeur) sur la commissures postérieures en posant la main à 45° par rapport à la ligne horizontale.
 - Introduire les doigts (index et majeur) en exerçant une pression postérieure (éviter de toucher le clitoris)
 - Explorer la paroi vaginale à la recherche:
 - Nodules
 - Tumeurs
 - Cicatrices
 - Points douloureux



- Arrivé au fond du vagin, tourner la main de 90°, paume contre le haut.



- Passer au-dessous du col afin de palper le cul-de-sac rétro-utérin (normalement vide)
- Évaluer le col:
 - Position: centré par rapport au vagin
 - Consistance: molle (grossesse), dur (cancer)
 - Contours: rond et régulier (irrégulier = cancer)
 - Mobilité: 2-3 cm de déplacement dans tous les côtés (immobile = cancer)
 - Douleur: indolore

- Palpation de l'utérus:
 - Placer la main dans le cul-de-sac postérieur.



Placer la main libre sur l'abdomen de la patiente à mi-distance entre la symphyse pubienne et l'ombilic.

Prévenir la patiente que vous allez déplacer la matrice et lui demander de vous indiquer si c'est douloureux.

- Avec la main vaginal (qui est sous le cul-de-sac), appuyer vers le haut et rapproche ainsi l'utérus vers la paroi abdominal qui est saisi par l'autre main.
- Apprécier :
 - La taille
 - La forme
 - La consistance
 - La mobilité
 - La présence de douleur ou de masses
- Palpation des annexes: ovaires:
 - Palper l'ovaire non douloureux en premier.



◦ Positionner les doigts de la main vaginale dans le cul-de-sac latéral et ramener l'ovaire vers la paroi abdominale.



- Palper l'ovaire avec la main abdominal (l'ovaire est sensible, la patiente peut guider l'examineur) et décrire:
 - Taille (taille d'une noix: 3,5x,2x1,5) (3 ans après la ménopause, l'ovaire n'est plus palpable)
 - Forme
 - Consistance
 - Mobilité
 - Tumeur
 - Douleur

PALPATION RECTO-VAGINAL

Le toucher recto-vaginal complète les informations que vous avez obtenues par l'examen vaginal. Il permet une palpation plus profonde d'un à deux centimètres. Il est particulièrement important lorsque l'utérus est rétro dévié.

- Prévenir la patiente que le vagin et le rectum vont être examinés simultanément et qu'elle aura peut-être l'envie de déféquer.
- A partir de la palpation bi-manuelle, retirer le majeur et l'introduire dans le rectum.
- Inspecter la cloison entre le vagin et le rectum:
 - Epaisseur
 - Présence de tumeurs
 - Présence de nodules
 - Douleurs



PALPATION RECTALE

Lors de l'examen rectal vous pouvez palper l'ampoule rectale, du cul-de-sac postérieur, la face postérieure du col et, pour un utérus rétroversé, aussi une partie du corps utérin.

- Prévenir la patiente que vous allez effectuer un toucher rectal.
- Introduire l'index (avec le majeur) préalablement lubrifié.
- Explorer les parois rectales.
- Retirer le doigt et informer la patiente de la fin de l'examen.

